

Universidad de Ciencias Pedagógicas
“Enrique José Varona”
Facultad: Educación Infantil
Carrera: Logopedia

**Título: Estrategia de comunicación aumentativa para un
escolar con limitaciones físico- motoras y anartria**

Trabajo de Diploma

Autora: Lidersy Arzuaga Manso
Tutora: Dr. C. Xiomara Rodríguez Fleitas
Profesora Titular, UCP EJV

La Habana, 2014

ÍNDICE**PÁG.**

INTRODUCCIÓN	1
DESARROLLO	
Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la comunicación aumentativa en escolares con limitaciones físico- motoras y anartria.	6
1.1- La comunicación aumentativa. Antecedentes y actualidad en el campo de la Logopedia.	6
1.2-La comunicación aumentativa en escolares con limitaciones físico – motoras y anartria. Sus particularidades.	12
1.3-Las estrategias de comunicación aumentativa utilizadas en la práctica pedagógica. Su fundamentación desde el enfoque histórico cultural.	22
El tablero de comunicación como estrategia de comunicación aumentativa para un escolar con limitaciones físico- motoras y anartria.	29
2.1- Operacionalización de la variable. Dimensiones e indicadores.	29
2.2-Análisis del proceso y los resultados del diagnóstico inicial.	30
2.3-Presentación de la propuesta, fundamentación y particularidades.	33
2.4-Valoración de los resultados de la aplicación de la propuesta	45
CONCLUSIONES	48
RECOMENDACIONES	49
BIBLIOGRAFÍA	50
ANEXOS	54

Introducción

El desarrollo alcanzado por la humanidad en los umbrales del siglo XXI ha impuesto a la educación mejores condiciones para satisfacer las demandas educativas de los escolares que presentan necesidades educativas especiales, por el hecho de contar con diferentes recursos profesionales, científicos y materiales que han tenido un impacto en los métodos dirigidos al tratamiento a los trastornos de la comunicación y el lenguaje, desde una perspectiva educativa que considere otras modalidades de comunicación, además de la tradicional.

Los escolares con severos trastornos de la comunicación como: la disartria, anartria, los retardos del lenguaje, el autismo, retraso mental profundo, la sordera y sordoceguera para cumplir con los objetivos del currículo y acceder a la cultura con igualdad de oportunidades que los demás, necesitan de un aprendizaje formal de los sistemas de comunicación aumentativa, para expresar sus ideas, sentimientos, deseos y necesidades mediante diferentes códigos, independientemente de sus limitaciones lingüísticas, físicas, cognitivas, sensoriales u otras, que dificultan el proceso comunicativo(Rodríguez, X. 2014:177).

Los sistemas de comunicación aumentativa son instrumentos que no interfieren el desarrollo de la comunicación oral en las personas con trastornos del lenguaje, por el contrario, pueden favorecer y aumentar las vocalizaciones en algunas personas. En este ámbito, existe un amplio número de mecanismos físicos (ayudas técnicas, formas alternativas de acceso al ordenador...), que permiten comunicarse mediante sistemas comunicativos con y sin ayuda externa para poder acceder al currículo y a la cultura universal en general (Torres, S. 2001:19).

La aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y de la comunicación y el lenguaje han entrañado nuevas expectativas en torno a la logopedia tradicional. Los tableros de comunicación se han convertido en comunicadores electrónicos con salida de voz (sintetizada o digitalizada). Mediante las “máquinas de hablar” y el aprovechamiento de los recursos de voz que ofrecen los ordenadores se ha conseguido que muchas personas con severos trastornos del habla tengan la posibilidad de comunicarse de una forma más próxima a la habitual.

El tema que se investiga ha sido abordado por diferentes investigadores. Sus antecedentes se ubican tanto en el ámbito internacional como nacional. Diversos estudiosos en el campo de la Logopedia han abordado esta temática. En el ámbito foráneo se destacan autores como: Scheffer (1980); Monfort (1982); Basil C y Puig R. (1988); Torres S. (1988, 2001); Rodríguez M.A. (1992); Escribano L. y Tamarit, J. (1996, 2002); (Díaz M.L. (2004); Schaeffer y Cols (2005), otros.

En Cuba se señalan los trabajos de Pérez E. (2001); Cruz M.D y Fernández I. (2002); Rodríguez X (2007); Figueredo R. (2007); Rodríguez X. y Cobas C. L. (2010); Fernández G. y Rodríguez X. (2014), entre otros.

Estos estudios resultan de gran interés para la comunicación de los escolares con limitaciones físico-motoras, que presentan disartria y anartria; por la necesidad de interactuar con el mundo que los rodea, expresar sus deseos, sentimientos y acceder a los objetivos del currículo en función de la continuidad de estudios. Al mejorar su comunicación se favorece también la elevación de su autoestima para el desarrollo de su personalidad.

En diferentes congresos como en Pedagogía (2003, 2005, 2007), en el de Logopedia y Foniatría (2004, 2006, 2008) y en otros eventos internacionales de Educación Especial convocados por el Centro de Referencia Latinoamericano efectuados cada año, se ha planteado la necesidad de la búsqueda de nuevas vías que permitan el máximo desarrollo posible de la comunicación de los escolares con disartria y anartria, a partir del impacto de los sistemas de comunicación aumentativa. Esta problemática cobra particular importancia en la escuela para escolares con limitaciones físico-motoras, donde existe un universo de educandos que necesitan del empleo de estos sistemas para su inclusión educativa. De ahí que en este trabajo se presente la siguiente **situación problemática**:

1. Carencias teórico-metodológicas en la aplicación de los sistemas de comunicación aumentativa en escolares con disartria y anartria.
2. Insuficiente empleo de los sistemas de comunicación aumentativa en los escolares con limitaciones físico-motoras asociadas a la disartria y anartria.

3. Necesidad de aprovechar las potencialidades de los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria para el uso de los sistemas de comunicación aumentativa.
4. Insuficiencias en la orientación educativa a la familia para el desarrollo de la comunicación aumentativa en esta población.

Esta situación problemática que se presenta en la práctica pedagógica revela la necesidad de plantear el siguiente **problema científico**: ¿Cómo mejorar el desarrollo de la comunicación aumentativa en los escolares con limitaciones físico -motoras y anartria? Con el propósito de solucionar el referido problema, se precisa como **objetivo**: Elaborar una estrategia de comunicación aumentativa para escolares con limitaciones físico-motoras y anartria, de la escuela especial Solidaridad con Panamá.

Para dar solución al problema científico se plantean las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Qué fundamentos teóricos y metodológicos sustentan el desarrollo de la comunicación aumentativa en los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria?
2. ¿Cuál es el estado actual del desarrollo de la comunicación aumentativa en un escolar con limitaciones físico- motoras y anartria, que cursa el quinto grado?
3. ¿Qué particularidades debe tener una estrategia de comunicación aumentativa aplicada a un escolar con limitaciones físico-motoras y anartria?
4. ¿Cómo valorar en la práctica pedagógica la aplicación de la estrategia de comunicación aumentativa?

En correspondencia con las preguntas científicas se presentan las **tareas de la investigación**:

1. Análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo de la comunicación aumentativa en los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria.

2. Caracterización del estado actual del desarrollo de la comunicación aumentativa en un escolar con limitaciones físico-motoras y anartria, que cursa el quinto grado, en la escuela especial Solidaridad con Panamá.
3. Diseño de una estrategia de comunicación aumentativa basada en pictogramas para favorecer el proceso comunicativo en un escolar con limitaciones físico-motoras y anartria, que cursa el quinto grado, en la escuela especial Solidaridad con Panamá.
4. Valoración de la estrategia de comunicación aumentativa aplicada en la práctica pedagógica.

Durante el proceso investigativo se emplearon **métodos teóricos y empíricos** como: el analítico- sintético; permitió profundizar en el estudio bibliográfico para la elaboración del marco teórico de referencia y la valoración del diagnóstico del problema que se investiga, así como los elementos necesarios y suficientes que fundamentan la propuesta.

El inductivo-deductivo; con el propósito de profundizar en las particularidades de los sistemas de comunicación aumentativa, en función de su empleo en los escolares con limitaciones físico-motas y anartria. La modelación: para realizar las abstracciones necesarias y conformar las ideas básicas acerca de la estrategia de comunicación aumentativa seleccionada, en correspondencia con las características de los usuarios.

También se utilizaron técnicas y **métodos empíricos**, entre los que se destacan: el análisis documental (ver anexo 1), la exploración logopédica (ver anexo 2), observaciones a clases (ver anexo 3), entrevista a maestros y a la familia (ver anexo 4 y 5), el estudio de caso (ver anexo 6), el cuaderno individual (ver anexo 7) como complemento de la propuesta y la encuesta a especialistas (ver anexo 8), quienes valoran su concepción en función de su perfeccionamiento. En el procesamiento de la información se aplicó el método matemático de análisis porcentual.

El **grupo de estudio** está formado por tres subgrupos: A, B y C.

El grupo A, está compuesto por un escolar con limitaciones físico-motoras y anartria, tiene 13 años y cursa el 5to grado con una adaptación curricular por las severas dificultades que presenta en la comunicación.

El grupo B, compuesto por siete maestros y dos directivos de la escuela especial Solidaridad con Panamá. Los primeros, el 100% son licenciados y dos tienen el título académico de Master en Educación Especial. Tienen una experiencia profesional que oscila entre 15 y 35 años.

El grupo C, formado por la familia con quien convive el escolar: la madre, el padre y la hermana. Se trata de un medio familiar funcional, aunque con bajo nivel cultural.

Actualidad científica:

La propuesta es actual en tanto contribuye a resolver una de las problemáticas fundamentales de la escuela: la comunicación de los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria. Por eso, se aprovecha el empleo de estrategias de comunicación aumentativa para favorecer su inclusión social. Además forma parte del proyecto dirigido a la atención educativa a las personas con necesidades educativas especiales, en el área de la comunicación, del Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial (CELAEE).

La temática se ha presentado en varias jornadas científicas, tanto a nivel municipal como en el evento base a Pedagogía 2015 de la UCP Enrique José Varona. Además, está seleccionado para el Congreso Internacional del Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial (CELAEE), en junio del 2014.

También se va a publicar en la Revista Joven Educador, fue avalado por la comisión científica del departamento de Educación Especial.

Desarrollo

I. Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la comunicación aumentativa en escolares con limitaciones físico- motoras y anartria.

1.1 La comunicación aumentativa. Antecedentes y actualidad en el campo de la Logopedia.

La comunicación es un elemento trascendental en el funcionamiento y formación de la personalidad. Su origen está asociado a la actividad del hombre y condicionada al lugar que ocupa dentro del sistema de relaciones sociales. Por eso, es fundamental considerar las particularidades de este proceso en las personas con discapacidad, en las que se dificulta el proceso comunicativo por diferentes causas, de orden individual y social, por las barreras que se presentan en la interacción con el entorno. En este sentido, coincido con la doctora Rodríguez, X. (2014:179), quien enfatiza en el valor de los sistemas de comunicación aumentativa en las personas que tienen severas dificultades para comunicarse mediante el lenguaje oral y escrito y necesitan de estos sistemas.

Estos educandos para cumplir con los objetivos del currículo y acceder a la cultura con igualdad de oportunidades que los demás, necesitan de un aprendizaje formal de los sistemas de comunicación con y sin ayuda externa, los que les permiten expresar sus ideas, sentimientos, deseos y necesidades mediante diferentes códigos, independientemente de sus limitaciones lingüísticas, físicas, cognitivas, sensoriales u otras, que dificultan el proceso comunicativo. Se trata de valorar la utilidad de estos sistemas que surgieron con el propósito de aumentar la capacidad de comunicación porque independientemente de su discapacidad, pueden y tienen derecho a disfrutar de una educación de calidad como los otros.

La finalidad de estos sistemas es aumentar el habla o sustituirla cuando la persona no puede hacer uso de su propio organismo para producirla, según Basil C (1998:624), quien además afirma que pueden expresarse mediante símbolos distintos a la palabra articulada. El objetivo está dirigido a desarrollar la capacidad de comunicación.

El hombre desde el punto de vista de su desarrollo histórico e individual, no puede vivir y satisfacer sus necesidades básicas sin comunicarse con sus semejantes. El estudio de la comunicación permite explicar cómo se da la comprensión entre los hombres en su actividad conjunta, en todas las esferas y grupos sociales en que participan durante su vida. Se trata de buscar vías, puentes para la comunicación interpersonal, cuando esta no es posible de forma natural. El propósito es facilitar la habilitación del sujeto hasta donde sea posible, porque lo más importante es la persona y todo lo demás debe adecuarse a ella y a sus circunstancias.

En la década de los 90 del pasado siglo, se hablaba de los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. En la actualidad, con frecuencia se habla de un concepto más amplio, el de comunicación aumentativa (CA), el que incluye todas aquellas opciones, sistemas o estrategias para facilitar la comunicación de toda persona que tiene dificultades graves para la ejecución del habla (Torres S., 2001:25).

La distinción entre sistemas alternativos y aumentativos es muy esclarecedora, independientemente del uso más frecuente de estos últimos. Los primeros, sustituyen totalmente al habla y los segundos, son un complemento, incluso, van más al habla que al lenguaje, como diferentes niveles de la comunicación. Generalmente se insiste en el factor de aumento de la comunicación. Para ello, se utilizan elementos mediadores como los pictogramas, tableros, signos manuales, entre otras estrategias que facilitan el proceso comunicativo.

Rodríguez, X. (2014:181), señala que el sistema de comunicación que se utilice debe adaptarse a las necesidades de los usuarios. Desde esta visión, el profesional se siente como un artesano capaz de moldear las herramientas con las que tiene que modelar y resolver el problema. Su preparación es muy importante para decidir qué sistema es más adecuado en cada momento y con cada persona, con la justificación científica que exige.

Torres, S. (2001:22) señala que los sistemas de comunicación aumentativa (SCA) representan conjuntos organizados de elementos no vocales para comunicar y no surgen espontáneamente, exigen de un aprendizaje formal. El fin es interactuar con el mundo, negociar significados, no importa el medio empleado ni su clasificación, lo más importante es tener el instrumento al servicio de la logopedia para ayudar al desarrollo de la

comunicación y el lenguaje, cuando se producen alteraciones por causas sensoriales, físicas o psíquicas.

Otros autores como Escribano L y Tamarit J (2002:17), señalan que en la utilización de estos sistemas en las personas con discapacidad se reconoce que ningún dato empírico disponible soporta el temor a un freno en el lenguaje. En realidad la literatura sugiere justo lo contrario. El hecho de que el desarrollo de habilidades de comunicación es crítico en el funcionamiento cognitivo general, justifica incluso que no hay prerequisites para el uso de estos sistemas.

Los sistemas de comunicación se refieren al método elegido como base principal para la comunicación, aunque no debemos circunscribirnos a un solo método o sistema, sino que serán enriquecidos por muchos elementos de otros sistemas o estrategias. La forma de acceso es el modo como la persona accede al sistema para transmitir el mensaje y el soporte comunicativo es el material o ayuda técnica que necesita para sustentar los signos o símbolos elegidos. Rodríguez, X. (2014:23) refiere que los sustentos teóricos de estos sistemas se fundamentan en una concepción semiótica, al reconocer esta ciencia que estudia el conjunto de los sistemas de signos, las estructuras y los procesos significativos.

Al tratar este tema es necesario puntualizar el concepto de código por su valor para la educación de las personas con discapacidad que son usuarios de la CA. Un código es un sistema de signos o señales que permiten formular y comprender un mensaje (Sales L. y Rodríguez X, 2008:33). En él se combinan letras, números u otros signos para la identificación abreviada de empresas, organismos, productos y cosas. Por ejemplo: oral, escrito, gestual, pictográfico, otros).

Los antecedentes de esta temática se ubican en la década de los años 80. Se empezó hablando de sistemas de comunicación no vocal, no oral, refiriéndose a “todo sistema de comunicación que no utilice palabras articuladas, pero que tenga suficiente nivel de estructuración convencionalizada para transmitir información. Se trata de una comunicación lingüística, sin que el emisor articule sonidos del habla”, según Puig de la Bellacasa, (1985:17).

Desde los últimos años del pasado siglo, se ha avanzado considerablemente en los SCA, así lo demuestran por ejemplo: el Programa de Comunicación Total de Schaeffer en 1980; el Bliss de Charles Bliss, en este año; la Comunicación Bimodal de Monfort et al. En 1982; la Palabra Complementada de Torres S, 1988. En este año, también Tamarit J. (p.30), enriquece la definición de comunicación no vocal al precisar que se trata de “un conjunto estructurado de códigos (verbales y no verbales), expresados a través de canales no vocales (gestos, signos, símbolos gráficos), necesitados o no de soporte físico, los cuales, mediante procesos específicos de instrucción, sirven para llevar a cabo actos de comunicación.

La aplicación y uso de estos sistemas deben concebirse como un programa global de intervención para desarrollar estrategias comunicativas y lingüísticas. Las acciones educativas deben estar contextualizadas a la vida real del sujeto y de su entorno familiar y social.

Los SCA se clasifican en dos grupos: sin y con apoyo externo, en coherencia con los usuarios y la selección de los sistemas. Los SCA sin apoyo, surgieron como ayudas para desarrollar el lenguaje y el habla. Estos sistemas no utilizan soportes externos al sujeto para comunicarse, son más manejables, dinámicos, autónomos y económicos y exigen mayores capacidades cognitivas. Los referidos sistemas, pueden presentarse sin ayuda externa al sujeto y con ayuda externa, en dependencia de la necesidad de usar elementos ajenos al propio sujeto que se comunica.

Los sistemas con ayuda externa, requieren de instrumentos para mejorar la producción del habla, por eso se recurre a la ayuda de sistemas ortográficos, pictográficos e informáticos, que suplan las dificultades expresivo-articulatorias del sujeto. Entre sus características se destacan algunas como: están basados en elementos muy representativos, en dibujos lineales (pictogramas), combinan símbolos pictográficos, ideográficos y arbitrarios.

Díaz, M. L. (2004:27), hace referencia a que en estos sistemas se busca enseñar a una persona un código distinto al oral, pero con el mismo fin que éste, comunicarse, expresarse, interactuar con el entorno y modificarlo mediante esta interacción para su inclusión social. Hay que reconocer que estos sistemas abren las puertas del mundo interior de este niño.

Los sistemas de comunicación aumentativa están dirigidos a las personas con limitaciones en la comunicación, con el propósito de ofrecerle una mejor calidad de vida, a partir de su participación social con igualdad de derechos que el resto de los individuos; al reconocer que la comunicación junto a la actividad, constituyen la base de la educación.

En los últimos 30 años se ha avanzado considerablemente en este campo, como resultado del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación; las corrientes psicopedagógicas a favor de una escuela inclusiva. Se trata de buscar vías, puentes para la comunicación interpersonal, cuando esta no es posible de forma natural. El propósito es facilitar la habilitación del sujeto hasta donde sea posible, porque lo más importante es la persona y todo lo demás debe adecuarse a ella y a sus circunstancias.

La comunicación aumentativa es un complemento, incluso, va más allá del habla que al lenguaje; generalmente se insiste en el factor de aumento de la comunicación. Para ello, se utilizan elementos mediadores como los pictogramas, tableros, signos manuales, entre otros, que se abordan más adelante.

El sistema de comunicación que se utilice debe adaptarse a las necesidades de los usuarios. De ahí la importancia de la preparación del profesional para decidir qué sistema es más adecuada en cada momento y con cada persona, con la justificación científica que exige. En la comunicación aumentativa se presentan conjuntos organizados de elementos no vocales para comunicar, mientras que por otra parte, están los sistemas espontáneos de comunicación basados en la mímica, el gesto natural o el lenguaje corporal, que constituye el primer idioma de las personas sordas y el patrimonio de su comunidad lingüística.

El primer objetivo de un sistema de comunicación aumentativo es desarrollar la capacidad de comunicación. Su aplicación y uso deben realizarse como parte de un programa global, nunca como una asignatura o actividades independientes. Debe ser un intento para la intervención, cuyo objetivo principal es el desarrollo de estrategias comunicativas y lingüísticas. Estos sistemas aumentativos según Lloyd y Parlan (1984) y (Basil, C. 1988) pueden clasificarse en:

Sistemas de comunicación sin ayuda. Estos no requieren ningún instrumento o ayuda técnica para que pueda tener lugar la comunicación, son los mismos mecanismos físicos que utiliza la persona que se comunica para transmitir sus mensajes.

Sistemas de comunicación con ayuda. Estos si necesitan de instrumentos o ayudas técnicas para que pueda ejecutarse la comunicación, ejemplos: sistemas basados en dibujos lineales (pictogramas) y sistemas basados en la ortografía tradicional.

Para la selección de un sistema de comunicación aumentativo se deben tomar en cuenta aspectos como: potencialidades para el desarrollo de la comunicación, funciones perceptuales, estado de motricidad general, capacidad cognitiva, estado emocional, particularidades del contexto institucional y familiar, ayudas educativas recibidas.

Por el valor que estos sistemas representan para el desarrollo humano, están concebidos en los planes de estudio de Carreras y Diplomados en Educación Especial, Logopedia y en la formación de maestros en Audición y Lenguaje en la formación inicial y permanente, los que en su desempeño profesional deben resolver problemas concretos de comunicación. De ahí que se justifique la necesidad de contar con herramientas especiales para tales fines.

Se trata de buscar vías, puentes para la comunicación interpersonal, cuando esta no es posible de forma natural. El propósito es facilitar la habilitación del sujeto hasta donde sea posible, porque lo más importante es la persona y todo lo demás debe adecuarse a ella y a sus circunstancias (Rodríguez, X 2014, en Logopedia II parte, capítulo 4).

Los sistemas de comunicación se refieren al método elegido como base principal para la comunicación, aunque no debemos circunscribirnos a un solo método o sistema, sino que serán enriquecidos por muchos elementos de otros sistemas o estrategias. La forma de acceso es el modo como la persona accede al sistema y/o sistemas para transmitir el mensaje y el soporte comunicativo es el material o ayuda técnica que necesita para sustentar los signos o símbolos elegidos. Los sustentos teóricos de estos sistemas se fundamentan en una concepción semiótica, al reconocer esta ciencia que estudia el conjunto de los sistemas de signos, las estructuras y los procesos significativos.

1.2 La comunicación aumentativa en escolares con limitaciones físico motoras y anartria. Sus particularidades.

Para la caracterización psicopedagógica de los escolares con diagnóstico de limitaciones físico-motoras y anartria, es necesario partir de las características del desarrollo ontogenético de los escolares del segundo ciclo, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años.

En este momento del desarrollo se inicia la etapa de la adolescencia, que en ocasiones también se le llama pre-adolescencia, donde el papel del grupo es fundamental en la toma de decisiones y en sus modos de actuación.

En el desarrollo intelectual, se puede apreciar que si con anterioridad se han ido creando las condiciones necesarias para un aprendizaje reflexivo, en estas edades se alcanzan niveles superiores ya que el escolar tiene todas las potencialidades para la asimilación consciente de los conceptos científicos y para el surgimiento del pensamiento que opera con abstracciones, cuyos procesos lógicos (comparación, clasificación, análisis y generalización, entre otros) deben alcanzar niveles superiores con logros más significativos en el plano teórico.

Lo antes planteado permite la posibilidad de plantearse hipótesis como juicios enunciados verbalmente o por escrito, puede también hacer algunas consideraciones de carácter reductivo (inferencias que tienen solo cierta posibilidad de ocurrir), que aunque las conclusiones no son tan seguras como las que obtiene mediante ese proceso deductivo, son importantes en la búsqueda de soluciones a los problemas que se le plantean. Todas estas cuestiones constituyen premisas indispensables para el desarrollo del pensamiento lógico de los escolares.

Al organizar y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje se deben tener en cuenta estas características, de modo que sea cada vez más independiente, que se puedan potenciar esas posibilidades de fundamentar sus juicios, de exponer sus ideas correctamente en cuanto a su forma y en cuanto a su contenido, de llegar a generalizaciones, ser crítico en relación a lo que analiza, a su propia actividad, a su comportamiento y al desarrollo de la creatividad.

Al terminar el sexto grado, el escolar debe ser portador, en su desempeño intelectual, de un conjunto de procedimientos y estrategias generales y específicas para actuar de forma independiente en actividades de aprendizaje, en las que se exija, entre otras cosas, observar, comparar, describir, clasificar, caracterizar, definir y realizar el control valorativo.

Debe apreciarse ante la solución de diferentes ejercicios y problemas, un comportamiento de análisis reflexivo de las condiciones de las tareas, de los procedimientos para su solución, de vías de autorregulación (acciones de control y valoración) para la realización de reajustes requeridos.

A partir del quinto grado, la aprobación del maestro comienza a ser sustituida por la aprobación del grupo, se plantea incluso que una de las necesidades y aspiraciones fundamentales en la adolescencia es encontrar un lugar en el grupo de iguales, el bienestar emocional del adolescente se relaciona con la aceptación del grupo.

En este momento las adquisiciones del escolar desde el punto de vista cognitivo, del desarrollo intelectual y afectivo-motivacional, deben alcanzar un nivel de consolidación y estabilidad que le permita enfrentar exigencias de mayor complejidad en la educación general media. Estas se expresan en niveles superiores de independencia, de regulación en su comportamiento y en su actividad de aprendizaje, así como en una mayor flexibilidad y reflexión en el desarrollo del pensamiento.

En este momento del nivel primario requiere, igual que los precedentes, atención pedagógica como sistema, donde la articulación del quinto con el sexto grado, se vea como una sola etapa que debe dar respuesta a los logros a obtener en el niño al término de la escuela primaria.

Específicamente en el quinto grado, etapa que se corresponde con el estudio realizado, el escolar debe continuar fortaleciendo el desarrollo de los sentimientos de admiración y respeto hacia los héroes, mártires, líderes de la patria, hacia los demás y hacia sí mismo, mantener una actitud laboriosa y valorar la importancia del trabajo del hombre y del suyo propio, comprender y aplicar medidas de Educación para la Salud, demostrar en distintas actividades la aplicación de conocimientos y habilidades intelectuales adquiridas, realizar en forma individual y colectiva tareas de aprendizaje, evidenciar habilidades en la utilización de la lengua materna, caracterizar y valorar de forma sencilla hechos y figuras

del país y la comunidad, interpretar y valorar los contenidos básicos de la Constitución de la República.

Además, es importante reconocer aspectos básicos sobre la sexualidad humana, desarrollo de habilidades en las técnicas computacionales, expresar emoción y orgullo ante los elementos de la cultura que caracterizan la cubanía y manifestar habilidades básicas y deportivas de acuerdo con el grado.

Los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria presentan severas dificultades para comunicarse mediante el lenguaje oral y escrito, por eso son usuarios de la CA, en la que pueden emplearse diversas estrategias comunicacionales que favorecen el proceso de atención educativa para su inclusión social. En este sentido, se basa también en el enfoque histórico-cultural desarrollado por L. S. Vigotski y sus seguidores (1989), en el que se profundiza en la relación sentido- significado, las funciones básicas del lenguaje: la noética y la semiótica, la relación pensamiento-lenguaje, la unidad existente entre las categorías actividad-comunicación-personalidad, la relación entre lo cognitivo y lo afectivo, el papel de la categoría vivencia a partir de las relaciones interpersonales y los procesos de mediación social.

Los referidos postulados son muy importantes en la práctica pedagógica con esta población por las severas desventajas que presentan en su desarrollo personal y social. La aplicación de los SCA en la población con limitaciones físico-motoras (LFM), en la que se consideran: “aquellas que provocan imposibilidad o disminución para realizar las actividades motoras propias de un grupo etéreo de manera permanente o transitoria, debido a la ausencia o insuficiente funcionamiento de los sistemas óseo-mioarticular y/o nervioso. Pueden combinarse con alteraciones emocionales, intelectuales, sensoriales, del lenguaje, u otras. Los factores causales son diversos y surgen en cualquier período de la vida”. (Navarro, S. 2006:9).

En el análisis de estas ideas, para la caracterización general de las personas con LFM es muy importante considerar los fundamentos vigotskianos referidos a la relación que se establece entre lo biológico y lo social en el desarrollo psíquico. En este caso, los factores biológicos tienen el papel de premisas para el desarrollo, mientras que los sociales constituyen la fuente del desarrollo, hay una unidad de relaciones dialécticas entre ambos, lo que explica el determinismo social del desarrollo psíquico.

Esta condición del desarrollo del sistemas óseo-mioarticular y/o nervioso, deviene en premisa, de ahí su carácter biológico, pero las condiciones sociales que se crean para su desarrollo, en este caso el empleo de un SCA que favorezca la comunicación y el aprendizaje, el acceso a la cultura con la utilización de diferentes mediadores, le imprime un carácter social y determinante en la formación de su personalidad, independientemente de su discapacidad físico-motora y del lenguaje.

Se ha de aprovechar la extraordinaria plasticidad y capacidad de aprendizaje del cerebro humano, a partir de las relaciones sociales en la actividad y la comunicación para educar a estas personas que no logran comunicarse por las vías tradicionales. En este proceso de experiencia histórico-cultural desarrolla conocimientos, habilidades y cualidades psíquicas en los productos de su trabajo, mediados por la cultura material y espiritual como base del desarrollo psíquico humano.

Al analizar las principales características y/o regularidades del desarrollo de estas personas, se destacan las siguientes: limitaciones en la autonomía física, la que puede ser desde muy personal o íntima como la imposibilidad de aseo de los genitales por sí mismo, alimentación, vestuario, hasta la participación activa en eventos sociales como la escolarización, el trabajo, el deporte, la recreación, entre otras actividades rectoras del grupo etéreo, que dificultan el autovalidismo; escasas vivencias sociales por las limitaciones o imposibilidad para el desplazamiento; en general se acompañan por un andador, muletas u otros auxiliares, que lo colocan en posiciones desventajosas.

Esta situación hace que en ocasiones la familia y hasta la propia persona con limitaciones decidan la no incorporación a actividades que, además del crecimiento emocional e intelectual, dificulte el acceso a la comunicación, al currículo y a la participación social. Además, de las barreras arquitectónicas y psicológicas existentes que crean un estigma negativo que frena la aparición de nuevas metas, las que al ser satisfechas, sientan las bases de una posición favorable ante sí y ante la sociedad.

Por otra parte, se evidencia la inmadurez intelectual, por la relación tan estrecha existente entre los procesos cognoscitivos y el propio desarrollo psicomotriz para la adquisición de vivencias. Al percibirse como un cuerpo incompleto, las limitaciones en la manipulación de objetos y reconocimiento de las partes del cuerpo, la lateralidad, entre otros elementos psicomotrices, se ven afectadas, lo mismo puede suceder ante alternaciones del tono muscular como de la sensibilidad.

Incluso, el hecho de no poder tirar la pelota, modelar en plastilina, garabatear, tomar el lápiz, correr, o saltar, propician que un cúmulo de habilidades y futuras capacidades para el desarrollo sensitivo se limiten, lo que explica el por qué de la inmadurez intelectual y las dificultades para la adquisición de la escritura, por los trastornos motores, la ausencia de miembros, o malformaciones en los brazos y manos, que dificultan este aprendizaje.

Además, las LFM que están directamente vinculadas a las alteraciones del lenguaje, como la parálisis cerebral (PC), según las estadísticas internacionales (Informe de la OMS del año 2005), es el trastorno motor que con más frecuencia desencadena limitación físico-motora en la infancia. La disartria es una alteración del lenguaje que se reconoce como el síntoma oral de la parálisis cerebral. Asimismo, en el caso más severo se manifiesta en una anartria.

Desde el punto de vista lingüístico, es frecuente la inmadurez oral, debido a la poca estimulación del lenguaje por parte de la familia y la desesperanza al ver la limitación física como centro y única razón de concentrar sus esfuerzos, sin tener presente el papel del lenguaje en el desarrollo intelectual, emocional y los beneficios que este reporta al niño. Por eso, se afectan las relaciones interpersonales y el establecimiento de nuevas amistades. Las miradas indiscretas y reacciones de asombro que se producen ante un cuerpo incompleto, la lástima por estar en una silla de ruedas, o la actitud de rechazo de los semejantes y familiares, crean situaciones difíciles para ellos.

Es necesario enfatizar en el afecto, el amor, en el desarrollo de la capacidad de comunicación que está tan dañada doblemente, por la LFM y el trastorno del lenguaje, en este caso, la anartria. Debe aprender a relacionarse, sin exceso de ayuda, que implica sobreprotección o sentimientos de minusvalía para el otro; se ha de potenciar el empleo de estrategias de comunicación aumentativa para satisfacer sus demandas educativas.

En la práctica pedagógica se manifiestan muchas carencias afectivas: su amor se reduce al que les brinda un miembro de la familia o su maestro, es por esto que se debe enseñar a amar su cuerpo, a los demás, a la naturaleza, a los símbolos patrios e incentivar todos los sentimientos positivos que de ellos se espera. Se sabe que es un proceso difícil, pero hay que estar preparado para acariciar un cuerpo incompleto o mal formado o hacer demostraciones de afecto a una prótesis como parte añadida del cuerpo, aprender a vivir con otras alternativas que favorezcan su desarrollo.

Como regularidad en esta población está presente la disfuncionalidad familiar, por las expectativas de esta ante la espera de un hijo sano, completo físicamente y hasta bonito; ante el nacimiento de uno con una limitación física, se desorganiza la familia y comienzan los conflictos, que transitan desde no creer y no confiar en el diagnóstico, hasta sentirse desesperanzados al confirmar que es real, con la aceptación de resignación, los complejos de culpa e inferioridad. También se afecta la economía familiar por la imposibilidad de reincorporarse a la actividad laboral, los gastos que se generan por los traslados a sesiones de fisioterapia u otros tratamientos. Se limita la relación profesional de uno de los padres (generalmente la mamá) por las ausencias o no reincorporación al centro de trabajo, situación que produce con frecuencia conflictos familiares, incluso el divorcio que generalmente se produce por el abandono del rol de pareja.

En la etapa de la adolescencia, se presentan dificultades en la orientación sexual, que se constatan, en correspondencia con el tipo de limitación física, se observará una mayor o menor repercusión en las posibilidades sexuales que todo ser humano posee. Son muy frecuentes las frustraciones, por el hecho de querer correr y no tener fuerza en las piernas o no contar con ellas, desear escribir y la malformación o la ausencia de extremidades superiores lo impida, el no control de esfínteres, estar confinado a una silla de ruedas, son entre otras, las realidades que desencadenan frecuentes frustraciones, inseguridad y gran preocupación por el futuro.

Cuando la LFM está asociada a un trastorno del lenguaje y la comunicación, por un daño neurológico como es el caso de la disartria y la anartria, se complejiza la atención educativa, la que exige de otras ayudas y recursos para satisfacer sus necesidades educativas especiales.

Al profundizar en el estudio del término disartria, son diversos los autores del área nacional e internacional que han abordado el tema; refiriéndose a sus causas, mecanismos de afectación y manifestaciones. En consecuencia se presenta la anartria como un trastorno más severo. Por ejemplo: Figueredo, E. y otros (1984: 106), plantea que es un trastorno orgánico del lenguaje, de carácter neurológico, provocado por lesiones en regiones centrales y en las vías conductoras del sistema motor verbal. Es evidente la insuficiente inervación de los órganos que intervienen en la emisión del habla, lo que trae como consecuencia trastornos en la pronunciación, afectaciones respiratorias, en el ritmo, la velocidad, la entonación, la voz y también en los aspectos léxicos y gramaticales del lenguaje, se altera todo el componente sonoro y se produce generalmente una insuficiencia general en el desarrollo del lenguaje.

Gorospe, J.M. y otros (1997:89), refieren la importancia de la exploración neurológica del sistema sensorial y motor, además de la evaluación física de los órganos articulatorios y el examen neurológico general, hacia la búsqueda de posibles alteraciones del tono, la fuerza y la coordinación de movimientos; así como el estado de la musculatura facial, mandibular, lingual, palatofaríngea y laríngea. Estos aspectos son muy importantes para el habla por la imprecisión de los movimientos que afectan la articulación de los fonemas en la ejecución motora. También se afecta la coordinación de la respiración y la fonación.

Por otra parte, los movimientos involuntarios pueden interrumpir temporalmente el discurso. Se ha de insistir en el resultado sonoro final, los síntomas acústicos con los componentes motores del habla, así como el diagnóstico topográfico de la lesión. Hay que considerar la afectación motora y del tono muscular.

El referido autor, señala entre sus características principales las siguientes: tono vocal elevado, descendido, con variaciones bruscas incontroladas; monotonía de la voz, temblor, variaciones excesivas de intensidad (alta, baja, normal); ritmo lento o acelerado, reducción de la acentuación, otras.

Fernández G. y Rodríguez X (2012) señalaron que en las disartrias se presentan alteraciones de uno o varios de los procesos motores básicos de expresión del lenguaje: respiración, fonación, articulación, resonancia y prosodia. En este sentido, en el año 1953, el médico inglés William John Little, al caracterizar la parálisis cerebral, considera la

existencia de trastornos del lenguaje que tienen su base en la motricidad articulatoria. Por su parte, el médico alemán Openjin en (1885), describe el cuadro clínico de la disartria, en el marco de las parálisis pseudobulbares. También, en ese mismo año, Gutzman, ofrece una amplia descripción de la disartria como trastorno de pronunciación.

El término parálisis cerebral es reconocido como una expresión general que abarca varios trastornos específicos los cuales se caracterizan por una lesión de los centros motores del encéfalo y se manifiestan por la pérdida del control motor. Se considera como uno de los trastornos del sistema nervioso central.

La disartria se clasifica en cinco formas fundamentales atendiendo a la localización de la lesión y el síntoma clínico que prevalece: disartria bulbar, pseudobulbar, cerebelar o cerebelosa, subcortical y cortical. Azcoaga, J (1981); Cabanas, R (1974); Figueredo, E (1984). Por tanto los tres síndromes motores, piramidal, extrapiramidal y cerebeloso del SNC, son determinantes en uno u otro tipo de parálisis.

En la disartria se altera la motricidad general, la que implica trastornos en el tono muscular y en el movimiento. Con frecuencia se evidencia una alteración de la actividad motriz en los músculos de la parte superior de la cara (movimientos de los ojos, las cejas, etc.); la cara se muestra inmóvil, anímica. Por otra parte, la motricidad general es torpe, se altera el validismo (no se viste y se calza solo), corre y salta de forma incorrecta, se dificulta la masticación y la deglución, que se evidencia en la abundante secreción de saliva (sialorrea).

Al tratarse del término anartria como trastorno agravado de la disartria, en cuanto al análisis sobre la etiología, consecuencias neurofisiológicas y psicolingüísticas y las manifestaciones verbales. Se valora como el síndrome agravado de la disartria que limita la emisión de los sonidos del lenguaje con la claridad necesaria para ser entendibles, pronunciar combinaciones silábicas, de palabras y oraciones, presentándose afectaciones en el componente sonoro de la lengua, entorpeciendo de manera significativa el desarrollo de la comunicación oral.

Se produce una deficiente articulación, con insuficiencia generalizada del desarrollo de todos los componentes de la lengua, severa afectación de la voz, la respiración, el ritmo, la fluidez, entonación, masticación, deglución y un grado mayor de afectación, con la

ausencia total del habla. Igualmente se señala la gravedad de otros procesos motores básicos de expresión del lenguaje como: fonación, resonancia y prosodia. La compensación del defecto oral discapacitante se presenta mediante el empleo de una jerga que resulta incomprensible, del apoyo en la comunicación extraverbal.

También, se presentan alteraciones en el oído fonemático a consecuencia de la deficiente retroalimentación del sistema sensorial auditivo-verbal que puede generar dificultades en la lectura y la escritura.

En general, la comunicación de los escolares con anartria se expresa fundamentalmente mediante gestos naturales, la mímica, la expresión facial y otros movimientos corporales que emplean para establecer sus relaciones con los demás, y muy especialmente para satisfacer todas sus necesidades; lo que tiene una significativa implicación en el aprendizaje escolar. De ahí que se impone la atención logopédica sistemática para compensar el trastorno, y además evaluar la posibilidad del empleo de los sistemas aumentativos para facilitar la comunicación.

Estos sistemas de comunicación aumentativa son sistemas que contribuyen a desarrollar estrategias de comunicación, regulan la conducta mejorando las relaciones interpersonales, reducen la ansiedad, crea un espacio más amplio para la comunicación y mejoran la interacción comunicativa, los signos manuales en los sistemas de comunicación sin ayuda como los símbolos ortográficos y pictográficos.

La atención logopédica para el desarrollo de la comunicación del escolar con anartria se realiza con el concurso de todos los agentes socializadores en el ambiente más normalizado y facilitador para el establecimiento de relaciones interpersonales y de interacción lingüística: el círculo infantil, la escuela primaria, la familia, la comunidad, como los ambientes que posibilitan al hombre la expresión de necesidades, afectos y favorecen el proceso de socialización.

El tratamiento de la anartria, por el carácter orgánico central y la base neurológica de la alteración, es largo y complejo, requiere de la participación de diferentes especialistas (médico - pedagógico) y sobre todo para la planificación adecuada del trabajo a realizar con estos casos, se hace necesario haber investigado a profundidad, para conocer las peculiaridades de la sintomatología del sujeto a tratar.

En los tratamientos logopédicos se deben desarrollar con sistematicidad, actividades para trabajar la sintomatología fundamental: motricidad general y articulatoria, eliminación del babeo o sialorrea, voz, respiración, ritmo y fluidez, pronunciación. Además se trabajarán el resto de los componentes del lenguaje, los procesos fonemáticos y el lenguaje escrito, en los casos necesarios.

Se debe enfatizar en el trabajo diferencial con la motricidad, teniendo en cuenta el síntoma neurológico de afección motriz que prevalezca, para lograr una adecuada compensación. Esta consideración es fundamental en su atención educativa por todos los agentes de socialización implicados.

La anartria por la expresión oral ininteligible, las severas dificultades en la motricidad; los trastornos en los órganos fonoarticuladores, justifican la necesidad del empleo de la comunicación aumentativa, como instrumento para favorecer las vocalizaciones en algunas personas.

En el ámbito interdisciplinario de los sistemas aumentativos de comunicación, existe un amplio número de mecanismos físicos (ayudas técnicas, formas alternativas de acceso al ordenador), que permiten los contactos comunicativos a personas con diferentes tipos de afectaciones en el área de la comunicación y el lenguaje.

La aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y de la comunicación y el lenguaje han entrañado nuevas expectativas en torno a la logopedia tradicional. Los tableros de comunicación se han convertido en comunicadores electrónicos con salida de voz (sintetizada o digitalizada). Mediante las “máquinas de hablar” y el aprovechamiento de los recursos de voz que ofrecen los ordenadores se ha conseguido que muchas personas con severos trastornos del habla tengan la posibilidad de comunicarse de una forma más próxima a la habitual.

A continuación en el próximo epígrafe se profundiza en la diversidad de estrategias de comunicación aumentativa utilizadas según las necesidades de los usuarios, con el propósito de desarrollar su capacidad de comunicación, independientemente de su discapacidad.

1.3 Las estrategias de comunicación aumentativa utilizadas en la práctica pedagógica. Su fundamentación desde el enfoque histórico cultural.

La comunicación aumentativa (CA) configura un amplio abanico de disciplinas que incluyen los marcos teóricos, los sistemas de signos para la comunicación, la aplicación de las nuevas tecnologías, las estrategias de enseñanza y algunas técnicas de intervención educativa.

En la atención educativa a las personas usuarias de los SCA, se emplean diversas estrategias como las planteadas por Torres Monreal y otros, quienes hacen énfasis en las habilidades de los usuarios de la CA, los que tienen grandes limitaciones para relacionarse con el entorno y desconocen las estrategias para la comunicación, además de que habitualmente reciben menos atención. Para su introducción es necesario facilitar situaciones controlables que ayuden a la anticipación de lo que va a ocurrir, al control de sus propias acciones sobre el entorno, para lo cual proponen tres estrategias de comunicación: anticipación, elección y representación, por ejemplo:

- 👉 El calendario de actividades; dirigido a la rutina diaria, favorece la estructuración espacio-temporal tanto en el hogar como en el centro educativo, el niño aprende a anticipar lo que va a suceder y a controlar sus acciones.
- 👉 El uso de objetos de referencia; le permite la interacción con el medio para comunicar necesidades y sentimientos mediante mecanismos que lo ayuden a hacerlo. Estos objetos ofrecen un punto de partida igual que si se utilizaran palabras articuladas y escritas. Lo que propicia la anticipación de lo que va a ocurrir, reducen la ansiedad e inseguridad, facilitan la expresión de necesidades y la autonomía personal, entre otras.
- 👉 La comunicación intencional; permite elegir el programa de comunicación en situaciones comunicativas reales como: conseguir varios objetos preferidos, distinguir los de alto interés y los que no le interese al usuario; preguntar al usuario lo que quiere y esperar una opción como respuesta, con el fin de proporcionarles claves visuales y verbales, cuando el alumno toque el recipiente que contenga el

objeto deseado, se le dará inmediatamente su duplicado para que vivencie el valor de representación.

👉 Introducción del lenguaje gestual; tiene como propósito que todas las actividades comunicativas se acompañen de gestos básicos relativos a actividades cotidianas (dormir, comer, aseo, juego) realizadas por el adulto a la vez que emplea el lenguaje oral. En el caso que existan problemas visuales se utiliza el apoyo físico, el aprendizaje del gesto mediante el movimiento refuerza la atención visual.

👉 La comunicación como proceso multimodal; la que enfatiza en aprovechar cualquier modo de expresión del niño, la que incluye por ejemplo: una sonrisa, un llanto, otros. Este debe percibir que es merecedor de ser atendido.

👉 Creación de tableros de comunicación; constituye una opción cuando una persona es capaz de reconocer representaciones de la realidad (objetos, personas, acciones) mediante dibujos o símbolos (pictogramas, lenguaje escrito, colores). Por ejemplo, las claves para la estructuración del Bliss.

Las estrategias de CA se clasifican de acuerdo con su uso y ajustada a las necesidades y potencialidades de cada persona. Por eso es útil reconocer en la práctica pedagógica la clasificación de Díaz, M. L. (2004: 19) al referirse a estas estrategias:

- Estrategias de anticipación como: calendario o agenda de actividades, vigilar, esperar y reaccionar acompañada de un pictograma.
- Estrategias de elección: comunicación intencional con el empleo de claves visuales, el panel de deseo y la búsqueda de objetos referidos para distinguir lo que quiere. También se emplea la cadena de construir-interrumpir.
- Estrategias de representación como: introducción del lenguaje gestual, el tablero de comunicación, dar información por adelantado, dar oportunidad de comunicación a partir del estilo comunicativo del interlocutor y dar el modelo de comunicación según las personas significativas para él.

A continuación se representa en una figura la diversidad de estrategias de comunicación aumentativa, las que tienen un valor metodológico de acuerdo con la intencionalidad comunicativa.

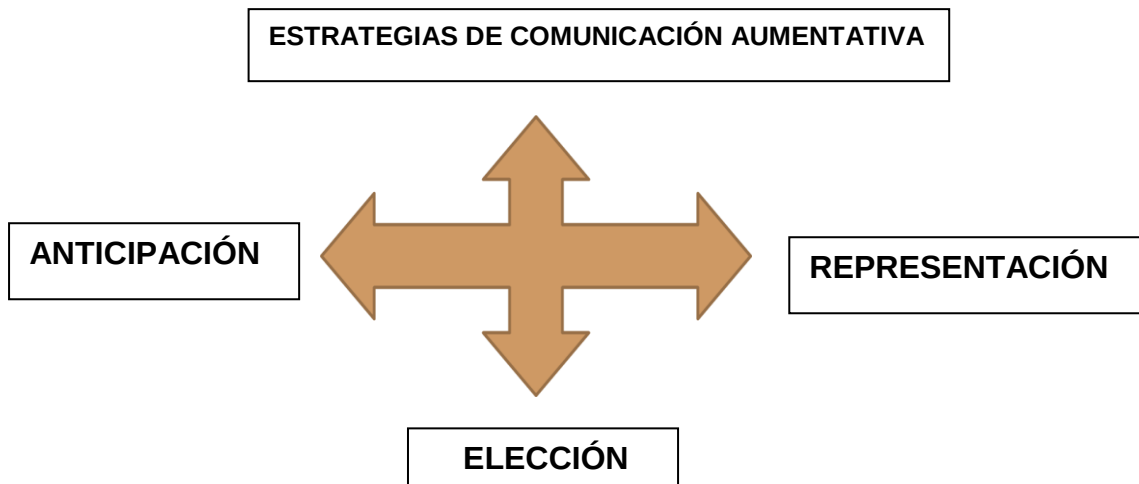


Fig.1. Representación de las estrategias de comunicación aumentativa.

En la comunicación con los escolares que presentan LFM y anartria, una de las estrategias más utilizadas la constituye **el tablero de comunicación**, el que está basado en símbolos pictográficos e ideográficos. Las condiciones óptimas para su aplicación deben ser las siguientes: tener buen nivel de comprensión, no tener dificultades visuales, buena retención y recuerdo de la información, la disposición de él y del grupo por aprender a utilizar el sistema.

Los tableros de comunicación son ayudas técnicas sencillas donde se ubican los signos; pueden ser de madera, cartón, plástico, en formato digital, de otros materiales. Se colocan delante del niño/a de manera que los interlocutores lo compartan. También pueden colocarse en una posición vertical delante de la persona para mantener un mejor contacto visual y físico. Estos tableros son económicos, fáciles de fabricar, de adaptar y mantener. Por ejemplo, con fines de anticipar acciones de actividades que debe realizar el escolar, se observa en el figura 2.

ASEO PERSONAL



Fig. 2. Anticipación de acciones para la comunicación

Para la selección de este sistema el diseño y adaptación de la ayuda debe ajustarse al máximo a la persona que se sirve de ella, en función de sus necesidades y capacidades. Siempre hay que preguntarse: ¿quién utilizará la ayuda?, ¿dónde la utilizará?, ¿para qué le sirve?, es fundamental la personalización de la ayuda en el tratamiento logopédico.

Los símbolos pictográficos para la comunicación (SPC), según Roxana Mayer Jhson (1981), fueron concebidos y elaborados en base a símbolos pictográficos (dibujos simples e icónicos). El hecho de estar basados en elementos muy representativos, en dibujos lineales (pictogramas), se combinan símbolos pictográficos, ideográficos y arbitrarios, los símbolos fueron diseñados para:

- Simbolizar palabras y conceptos de uso más común, en la comunicación diaria.
- Ser utilizados para cualquier grupo de edad.
- Ser producidos clara y fácilmente en máquinas fotocopadoras.
- Ser separados fácilmente, de manera que solo sea necesario utilizar símbolos necesarios para un individuo concreto.
- Poder usar símbolos idiosincrásicos.
- Distinguirse unos de otros de manera fácil y rápida.

El vocabulario del SPC es variado y se divide en categorías y colores diferentes, similares al sistema Bliss como por ejemplo: las personas representan el color amarillo (incluye los pronombres personales), las acciones o verbos, el color verde, los adjetivos y adverbios con el color azul, nombre de los objetos con el color naranja, la diversidad de términos (miscelánea) con el color blanco y las palabras usadas en interacciones sociales se representan con el color rosado o morado.

Entre las ventajas de este sistema se señalan: localización rápida del símbolo, ayuda en la estructuración de las frases sencillas y resultan muy atractivos y motivadores. Es muy importante tener en cuenta algunas consideraciones para el uso y aprendizaje de estos sistemas, ellas son:

- La familia, los tutores y el logopeda desempeñan un papel clave en el éxito de su aprendizaje.
- El logopeda debe motivar al niño/a para facilitar su aprendizaje, con la ampliación de las ayudas y estrategias de acuerdo con el usuario.
- Antes de proceder al aprendizaje del SPC, se debe seguir un programa de percepción visual, es recomendable tener una idea clara del comportamiento de las áreas de percepción: discriminación visual, figura fondo, memoria visual, relaciones espaciales y constancia de la forma.
- El sistema está indicado en aquellas personas que tienen un nivel de lenguaje expresivo muy limitado y unas estructuras de frases cortas.
- Para emplear este sistema la persona debe reconocer objetos y dibujos y tener ciertas posibilidades de memorización.
- La persona usuaria del sistema debe tener un mínimo de intencionalidad comunicativa y el SPC se adapta a las circunstancias individuales.

En la población con LFM y anartria es frecuente el empleo de estos sistemas y/o estrategias de CA por las particularidades descritas, de hecho son niveles de ayuda que facilitan la comunicación por su carácter representativo y también anticipativo y electivo según la situación comunicativa, que lo caracteriza como clave visual. Esta estrategia no solo permite la comunicación y el aprendizaje, sino que eleva la autoestima y en general la esfera afectivo-volitiva de la persona por lo que significa para su desarrollo personal y social.

Al analizar la variedad de estrategias de CA utilizadas en la práctica logopédica por su amplio campo de acción, y en particular en las personas con LFM y anartria, es evidente la concepción humanista que se emplea, la que pone énfasis en el proceso de mediación social con el empleo de niveles de ayuda, tanto de forma externa como con su propio cuerpo, a partir de su intencionalidad comunicativa.

L.S. Vigotski (1984:146) promueve en su enfoque una idea principal que constituye una plataforma de la investigación: las funciones psíquicas superiores tienen un origen histórico-cultural, se enfatiza en la idea de que el hombre es un ser social por naturaleza, producto de la sociedad, así lo precisa al expresar. "... todas las funciones psíquicas superiores no se forman en la biología, en la historia de la filogénesis pura, sino en el mecanismo mismo que se encuentra en la base de las funciones psíquicas superiores, en el marco de lo social".

Desde el referido enfoque, se profundiza en tres teorías: la actividad, la comunicación y la personalidad. Sus sustentos son muy importantes para el desarrollo de esta investigación porque el hombre se forma y se desarrolla en la actividad, a partir de la comunicación que establece con los otros, accede a la cultura y desarrolla su personalidad. Con un fundamento dialéctico-materialista se refiere al desarrollo de las funciones psíquicas superiores, en contraposición con las posiciones biologicistas y el desarrollo de la cultura lo concibe como un proceso independiente de la historia real de la sociedad.

Este ilustre psicólogo señala que las funciones psíquicas tienen su historia y se desarrollan durante todo el ciclo vital, con nuevos matices en cada etapa de vida del desarrollo evolutivo del ser humano. Por eso, son producto de la apropiación histórico-social acumulada porque la sociedad es considerada cultura, según este enfoque. Se opera con

productos materiales y espirituales en determinados grupos sociales y en momentos históricos específicos. Sobre este, en particular, se destaca en la página de referencia las siguientes ideas de Vigotski: “la cultura es el producto de la vida social y de la actividad social del hombre y por eso el propio planteamiento del problema del desarrollo cultural ya nos introduce directamente en el plano social del desarrollo” (ibídem).

De acuerdo con estas ideas, se comprende el papel decisivo que se le concede a la cultura en el desarrollo humano. En este caso, cuando se trata de una persona con necesidades educativas especiales, que también necesita apropiarse de las distintas formas de la experiencia social, necesita ayuda y recursos específicos para su desarrollo personal y social, exige de la creación de situaciones sociales del desarrollo que favorezcan sus demandas educativas. Este proceso se inicia en la familia y se continúa en la escuela y en la sociedad.

En la consideración de esta teoría es fundamental valorar la relación entre lo biológico y lo social en el desarrollo psíquico, los primeros tienen el papel de constituir premisas para el desarrollo, mientras que los segundos son considerados como fuente del desarrollo, lo que explica el determinismo social del desarrollo psíquico. De ahí el valor que tiene la profundización en el diagnóstico psicopedagógico para ofrecer una respuesta educativa que se ajuste a sus necesidades y potencialidades.

Las condiciones biológicas son necesarias para el desarrollo del psiquismo, las que no existen sin el cerebro humano, así como tampoco existirían sin las cualidades psíquicas humanas. El cerebro humano posee una extraordinaria capacidad y plasticidad que lo diferencia del cerebro de los animales (Betancourt y otros, 2012:3).

En la infancia se produce la maduración intensiva del organismo del niño, en particular, la maduración de su sistema nervioso y del cerebro. Durante los primeros siete años de vida, la masa cerebral crece aproximadamente tres veces y medio, varía su estructura y se perfeccionan sus funciones. La maduración del cerebro es muy importante para el desarrollo psíquico porque se incrementan las posibilidades para la asimilación de diferentes acciones, se crean las condiciones que propician un aprendizaje cada vez más sistemático y dirigido.

2. El tablero de comunicación como estrategia de comunicación aumentativa para un escolar con limitaciones físico- motoras y anartria.

2.1 Operacionalización de la variable. Dimensiones e indicadores.

La variable se denomina *la comunicación aumentativa en la educación de escolares con limitaciones físico-motoras y anartria*. Se refiere al empleo de una estrategia basada en pictogramas, que facilita la comunicación en los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria, por presentar dificultades graves para el habla y exige de un aprendizaje formal, dirigido a su atención educativa.

A partir de esta definición operacional se precisan como dimensiones: *atención educativa* y *comportamiento del escolar*. La primera, según Betancourt, J. y otros (2011), señala que se trata de un proceso activo, interactivo y participativo que integra a los escolares y diferentes agentes de socialización para promover los cambios en el desarrollo del niño, a partir de un continuo proceso de estimulación, que organice acciones, ayudas oportunas y eficaces orientadas al desarrollo integral de los educandos. La segunda, está dirigida a constatar el desarrollo de habilidades sociales a partir de la interacción con los otros.

En la primera dimensión se precisan los indicadores siguientes:

-  Dominio de las estrategias de comunicación aumentativa
-  Uso de estrategias representativas
-  Establecimiento de un clima de confianza y seguridad.
-  Empleo de niveles de ayuda.

En la segunda dimensión los indicadores son:

-  Adquisición de vivencias con la ayuda externa.
-  Estado de la motricidad articularia
-  Uso de códigos
-  Aceptación de otros niños en el proceso interactivo.

En la atención educativa, cuando se investiga en la práctica pedagógica mediante diferentes instrumentos es necesario que los maestros y especialistas dominen de las estrategias de comunicación aumentativa señaladas en el epígrafe anterior, es decir: las de

anticipación de las acciones, las electivas y las representativas que evidencian la intencionalidad comunicativa mediante claves visuales.

En este sentido, es muy importante conocer el cúmulo de información que abarca la estrategia de representación y que de hecho es la que más se utiliza. En este empeño, la creación de un clima de confianza y seguridad donde se estimulen sus logros y lo motiven a hablar, a comunicarse para que aprecie su evolución y capacidad de comunicación y aprendizaje es fundamental. Asimismo como el empleo de otros niveles de ayuda porque todas las estrategias de comunicación aumentativa constituyen niveles de ayuda para el escolar.

En el comportamiento del escolar, al explorar los indicadores de esta dimensión hay que considerar bien en la exploración la adquisición de vivencias con la ayuda externa que se le ofrece en diferentes situaciones comunicativas, así como constatar el estado de la motricidad articular para ajustar la ayuda en función del escolar. También indagar los tipos de códigos que emplea para desarrollar la capacidad de comunicación.

Otro indicador de gran valor en el proceso investigativo que debe observarse es la aceptación de los otros niños/as en el proceso interactivo, tanto en las clases de las diferentes asignaturas del currículo como en otras actividades que evidencien la condición de inclusión.

Los referidos indicadores de ambas dimensiones se evalúan a partir de los criterios siguientes: alto, medio y bajo. En el anexo 3 aparecen los descriptores de medida.

2.2 Análisis del proceso y los resultados del diagnóstico inicial.

En el diagnóstico del problema que se investiga se analizan los resultados de los instrumentos aplicados a partir de las dimensiones e indicadores señalados anteriormente.

En el análisis documental (anexo 1), al ser analizados los documentos metodológicos dirigidos al proceso de atención educativa al niño con diagnóstico de sordoceguera (expedientes logopédicos, psicopedagógicos y libretas de orientación a padres y a maestros por parte de los especialistas) se pudo constatar que es insuficiente el tratamiento que se le da a los sistemas de comunicación aumentativa, tanto con ayuda como sin ayuda externa. En ocasiones se refieren a algunos de ellos y no lo reconocen como tales, generalmente utilizan el objeto de referencia y el calendario de actividades, sin embargo no hacen referencia a esos términos, por eso se valora el análisis documental de BAJO.

En la exploración logopédica realizada se constatan las severas dificultades que presenta el escolar. En el examen específico del habla se aprecia marcada torpeza lingual, no tiene instaurado casi ningún sonido del idioma, presenta paladar hendido, con un ligero prognatismo. La audición es normal.

La conversación la realiza con severas dificultades apoyándose en la mímica y gestos ilustrativos contextuales. El vocabulario es limitado y también el empleo de estructuras gramaticales, se comunica mediante palabras aisladas acompañadas de gestos. Su comprensión está conservada, ejecuta órdenes sencillas. Necesita niveles de ayuda de manera permanente tanto para el trabajo con la pronunciación como la motricidad general y articulatoria.

Por las dificultades que presenta en el habla no es posible caracterizar las cualidades de la voz, ni el ritmo ni la fluidez, en general el componente sonoro del lenguaje está severamente afectado. Su lectura es silábica, comprende lo que lee con niveles de ayuda a partir de preguntas de apoyo. Solo realiza algunos rasgos caligráficos.

En la conducta observada en la exploración logopédica se debe destacar que se mostró atento, disciplinado, obediente y con buen estado emocional. Su diagnóstico logopédico se concreta en un trastorno del nivel comunicativo habla, específicamente una disartria severa que se revela en una anartria, presenta una parálisis cerebral.

En la observación a clases en las indagaciones iniciales, el comportamiento de los indicadores en las dos dimensiones se precisa a continuación en la fig.3.

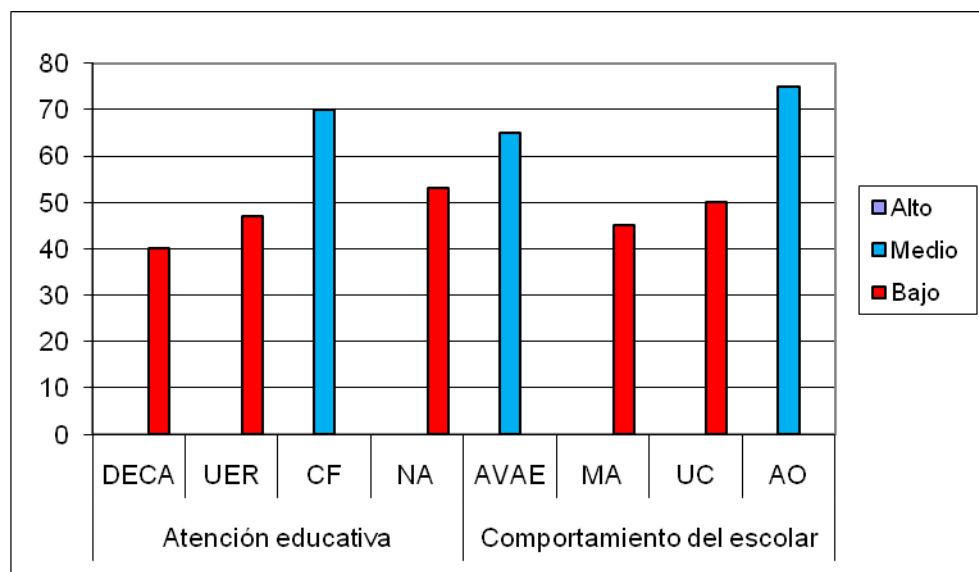


Fig.3 Diagnóstico inicial

En la primera dimensión referida a la atención educativa, como se visualiza en el esquema, el indicador dominio de las estrategias de comunicación aumentativa, los resultados fueron bajos; en el uso de estrategias representativas también resultaron bajos; en el establecimiento de un clima de confianza y seguridad la valoración fue de medio y en el referido a los niveles de ayuda fue bajo.

En la segunda dimensión, donde se analiza el comportamiento del escolar, la adquisición de vivencias con la ayuda externa es media; el estado de la motricidad articular es bajo, el uso de códigos también es bajo y la aceptación de otros niños en el proceso interactivo es media.

Al realizar una valoración general de ambas dimensiones, se constatan las dificultades en la práctica pedagógica referidas a la aplicación de los sistemas de comunicación aumentativa en la población con LFM y anartria. Solo tres indicadores resultaron ser evaluados de medio (37,5%) y el resto (62,5%) es bajo.

En la entrevista a los maestros y directivos se pudo constatar las insuficiencias que presentan en el conocimiento de los sistemas de comunicación aumentativa, las que se revelan en los resultados siguientes:

En el conocimiento y utilización de estos sistemas en la población con limitaciones físico-motoras y anartria, el 55,5% tiene información de manera general y se refieren al empleo de algunos sistemas como: los gestos y los pictogramas. Solo el 44,4% establece un clima de confianza y seguridad, en esencia desconocen cómo hacerlo con la aplicación de estos sistemas.

Los argumentos acerca del valor que le conceden a estos sistemas coinciden con la respuesta anterior, solo el 44,4% explica su influencia en el aprendizaje y la preparación para la vida. En la adquisición de vivencias, el 55% refiere cómo potenciar este aspecto para la comunicación y el aprendizaje mediante excursiones, observación de videos, trabajo con software educativo, otros.

El indicador que reveló mejor dominio fue el trabajo que se hace con la motricidad, la terapia ocupacional, la postura, los masajes y otros típicos de la especialidad. En este sentido, el 72,2% hizo referencia a este aspecto. Asimismo, como el empleo de códigos y la aceptación de los otros en el proceso interactivo, los resultados fueron de 66,6%, en comparación con los anteriores.

Es significativo señalar que es débil el trabajo que se realiza por el desarrollo del lenguaje y la comunicación, se enfatiza más en la motricidad, esto no solo repercute en sus habilidades sociales y su preparación para la vida, sino que tiene una incidencia negativa en la formación de su personalidad, crecen con una autoestima baja que dificulta su desarrollo personal y social.

2.3 Presentación de la propuesta, fundamentación y particularidades.

El tablero de comunicación constituye una estrategia de comunicación aumentativa que se apoya en el canal visual para acceder a la información, en él se representan símbolos pictográficos (dibujos simples e icónicos). Tiene una funcionalidad anticipatoria y representativa cuando se intenciona la comunicación como parte del SPC. También se combina con otras estrategias como los gestos de uso común y códigos gestuales para configurar el mensaje.

Desde el punto de vista filosófico se basa en la dialéctica materialista como base teórica y metodológica de todas las ciencias, al analizar los fenómenos y objetos de la realidad con objetividad a partir de la situación histórica concreta y de su relación con el sistema de influencias educativas.

Al valorar los fundamentos pedagógicos, se ha de considerar las funciones básicas de la educación social: instructivo-educativa, formativo-desarrolladora y socioindividualizadora. Se instruye y se educa porque es necesario formar valores y debe existir una estrecha relación entre lo cognitivo y lo afectivo, se trata de desarrollar una cultura que implica diferentes saberes y modos de comportamiento para educar la personalidad. También las categorías enseñanza, aprendizaje y desarrollo están dirigidas al cambio educativo en función de su desarrollo.

El sustento psicológico se fundamenta en el enfoque histórico cultural del desarrollo humano, en el que se revela la relación de lo biológico y lo social. La condición del desarrollo solo constituyen premisas biológicas, pero lo que determina son las condiciones de educación y desarrollo del sujeto, mediadas por un entorno social potenciador del desarrollo. Otros de los principios que justifican este enfoque son la unidad del pensamiento y el lenguaje, y la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, así como la mediación social del desarrollo psíquico (papel de los otros, Zona de Desarrollo Próximo) y la categoría vivencias, las que favorecen la adquisición de la experiencia histórico cultural para su desarrollo psicológico.

Desde el punto de vista lingüístico considera la complejidad del lenguaje y el amplio campo que abarca de acuerdo con sus usuarios, en este caso por las severas dificultades para el habla se utilizan los sistemas de comunicación aumentativa. Además, se emplea el enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua, privilegia la creación de situaciones comunicativas adaptadas a la condición del desarrollo de las personas.

A continuación se ilustra el esquema de la propuesta (observar la fig.4)

Esquema de la propuesta.

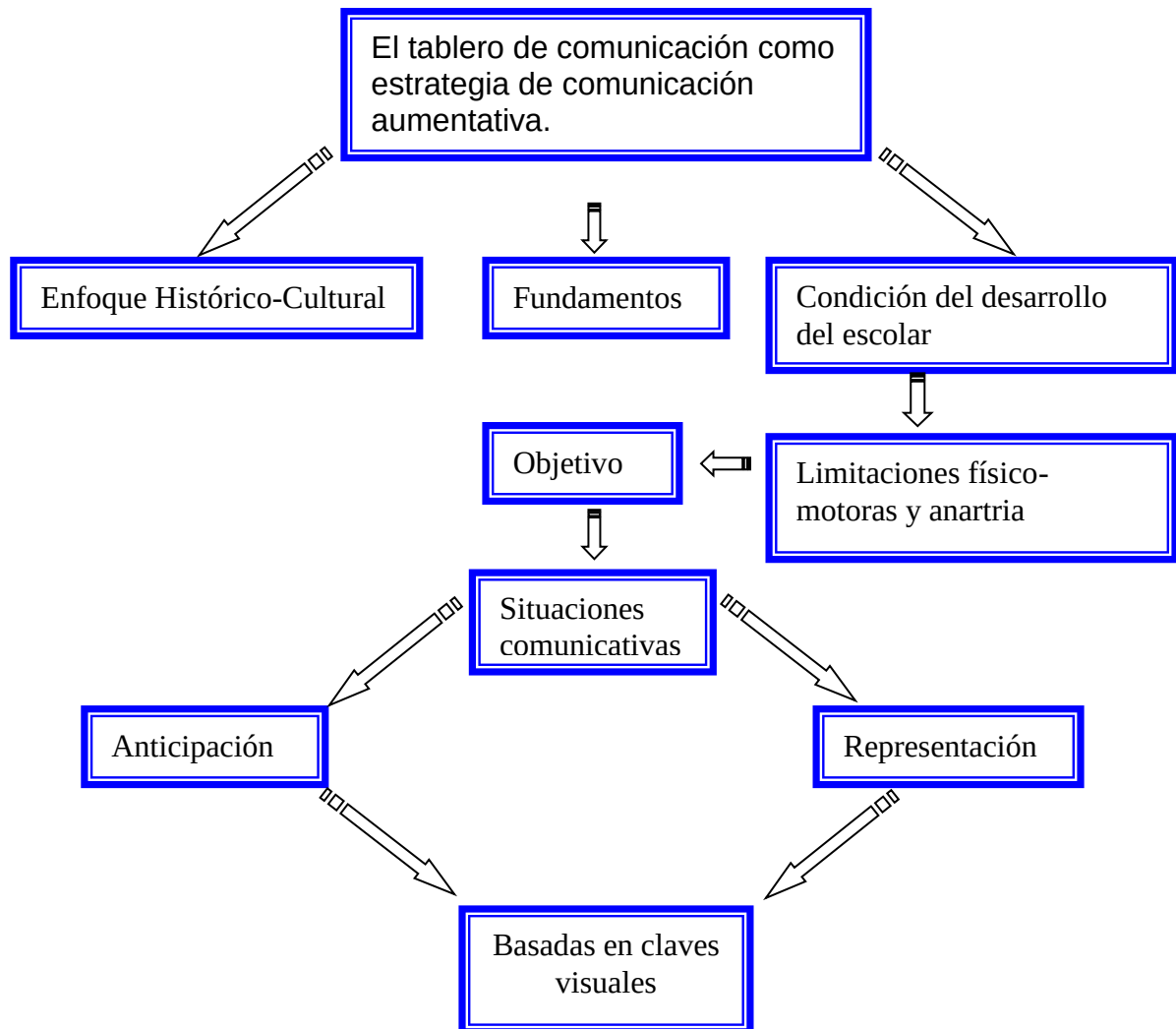


Fig. 4 El tablero de comunicación

La fig.4, se representan las particularidades de la estrategia de comunicación aumentativa, la que parte de los fundamentos del enfoque histórico cultural porque en esencia se trata de un proceso de mediación social con el empleo de niveles de ayuda, los que se concretan en diversas estrategias de comunicación aumentativa. Además de la aplicación de otros postulados de este enfoque como: la unidad en la relación pensamiento-lenguaje, la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, la Zona de Desarrollo Próximo, la categoría otros y la creación de situaciones sociales del desarrollo.

Por otra parte, las particularidades de los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria como condición del desarrollo, para ajustar la estrategia comunicativa a los usuarios, en función de su desarrollo. Se emplean situaciones comunicativas mediante pictogramas con acciones de anticipación y representativas, basados en claves visuales y que responden a las particularidades siguientes:

- 👉 Buen nivel de comprensión del usuario.
- 👉 No tener dificultades visuales.
- 👉 Buena retención de la información.
- 👉 Disposición por la utilización del sistema.

En la propuesta se presentan catorce tableros de comunicación representados por pictogramas, los que se acompañan del cuaderno individual para el escolar (ver anexo 7). Esta estrategia de comunicación aumentativa basada en claves visuales con elementos representativos que también tienen una intencionalidad anticipatoria para desarrollar la capacidad de comunicación, a partir del respeto a la condición del desarrollo de la persona.

A continuación se presenta cada uno en diferentes situaciones comunicativas. Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Presentación del tema a tratar.
2. Se establece una conversación mediante los elementos representativos del sistema para su aprendizaje.
3. Se estimula al usuario en las respuestas adecuadas en coherencia con las preguntas que revelan su comprensión.

4. Se enfatiza en las acciones a realizar para el desarrollo del pensamiento lógico-verbal.

5. Se entrena al usuario en la retención de la información a partir de ejercicios de memorización del tema.

6. Se usa como medio fundamental para la realización de actividades docentes como: marcar con una X, señalar, ejercicios de verdadero o falso, colorear, rellenar, circular, otros.

7. Práctica sistemática con el empleo del tablero de comunicación mediante el cuaderno individual.

En la medida en que el usuario se va entrenando en el empleo de esta estrategia comunicativa, se complejiza el nivel de comprensión y análisis de la situación comunicativa, así como de las propias producciones del escolar en los diferentes contextos, que evidencien la solidez en su aplicación.

Su aplicación no es solo en el tratamiento logopédico, sino en el salón de clases y en el contexto familiar como vía para la comunicación y el acceso al aprendizaje. Por eso es importante orientar a todos los agentes de socialización para favorecer este proceso. Se trata de utilizar esta estrategia con el propósito de desarrollar la capacidad de comunicación por su implicación en el aprendizaje y en la formación de la personalidad.

La propuesta puede diversificarse en función del desarrollo de las necesidades de los usuarios a medida que se van entrenando en el sistema, por su empleo se reconoce su valor en las personas con severas dificultades para comunicarse mediante la vía oral.

A continuación se presentan los diferentes tableros de comunicación propuestos.

Fig.5 Anticipación de acciones para almorzar



Fig.6 Anticipación de acciones para merendar



Fig.7 Acciones a realizar en la escuela y con la familia

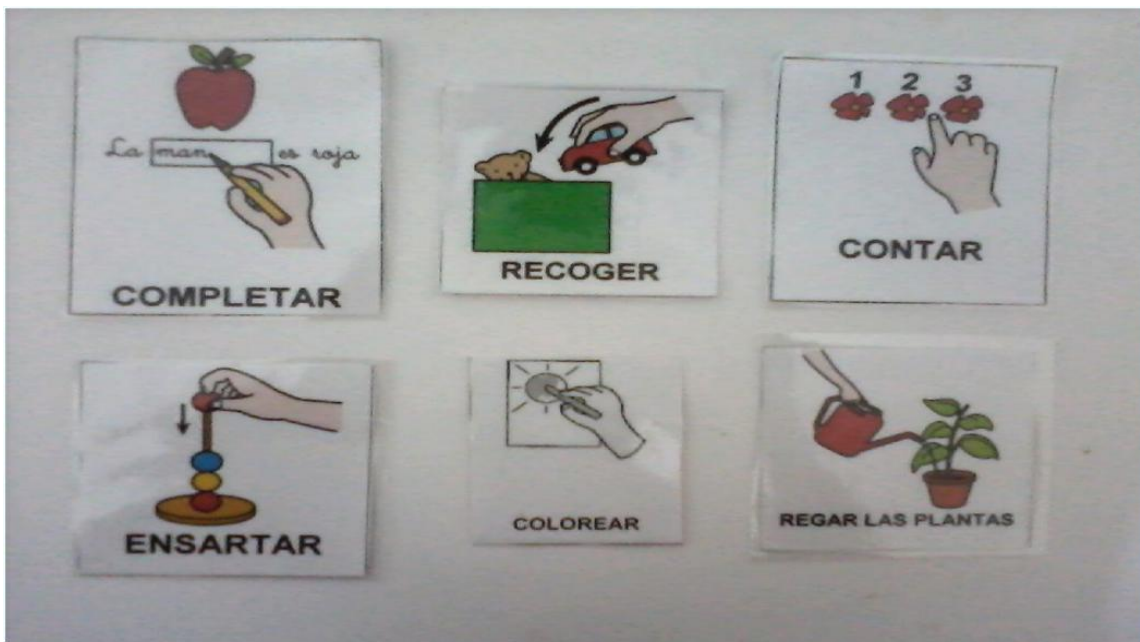


Fig.8 Acciones relacionadas con el contexto familiar



Fig.9 Útiles del comedor



Fig.10 Un paseo al zoológico



Fig.11 Útiles para el trabajo con la motricidad



Fig.12 Las expresiones del rostro

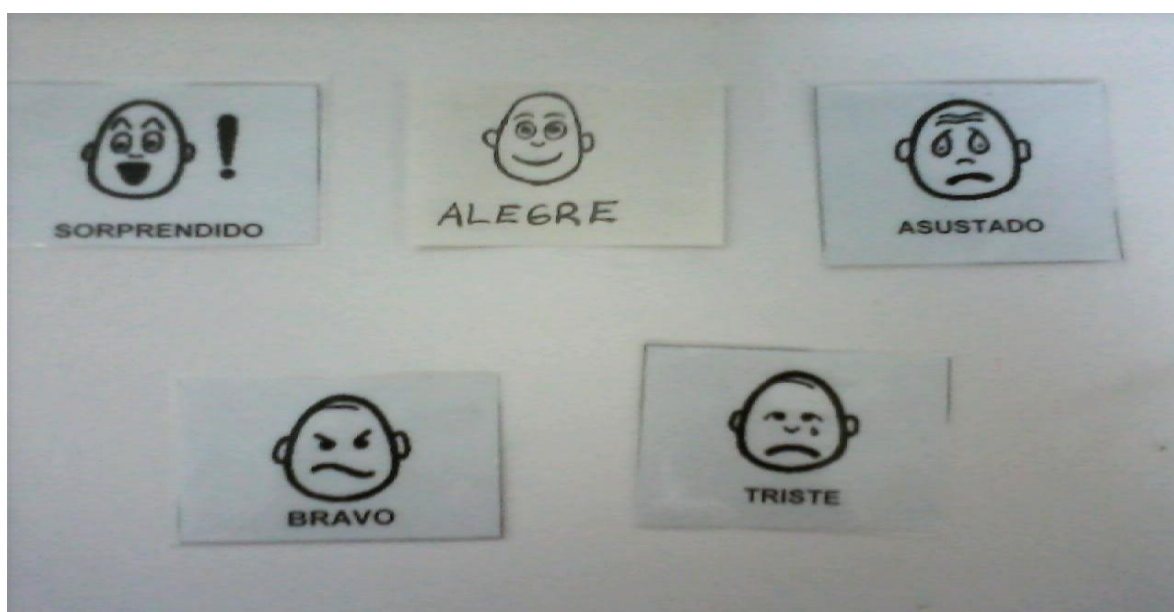


Fig.13 Aseo personal



Fig.14 Los saludos



Fig.15 Generalizaciones



Fig.16 Calendario de actividades

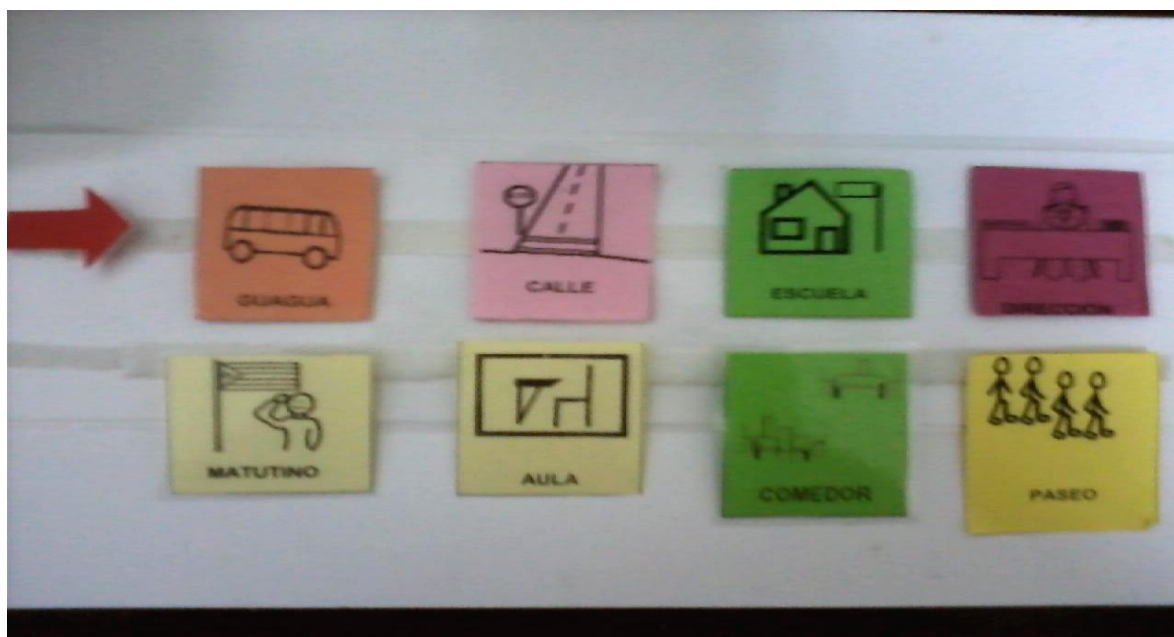


Fig.17 Yo quiero...

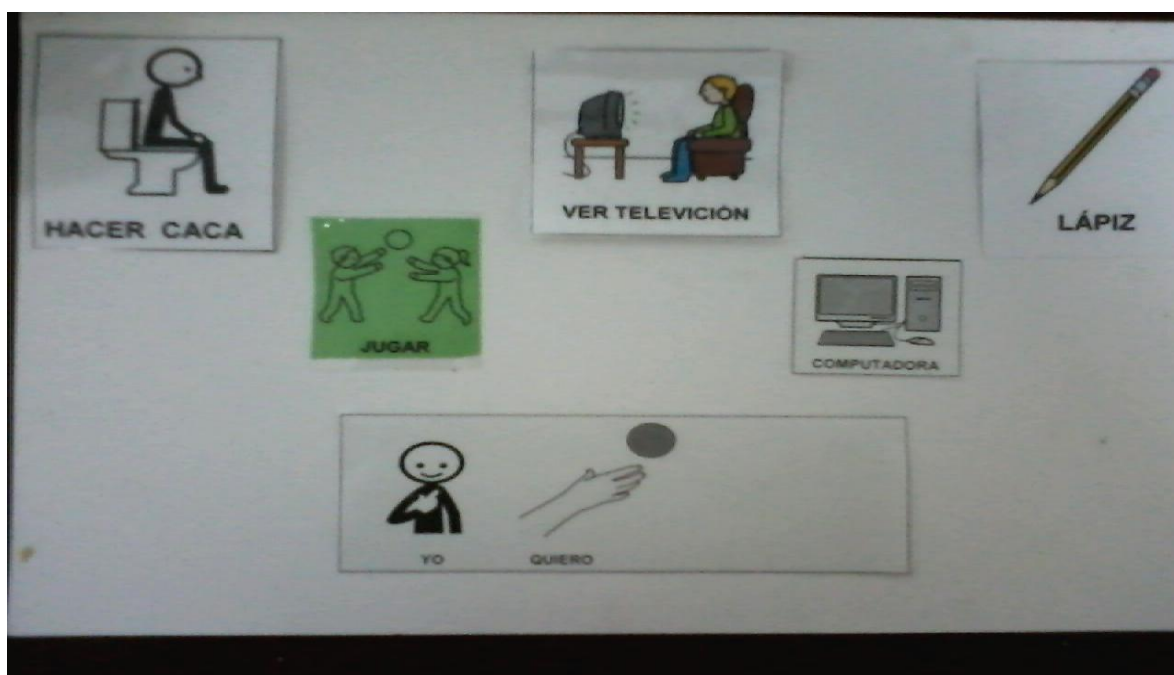


Fig.18 Otras acciones a realizar



En la atención individual al escolar con LFM y anartria a partir del empleo de los referidos pictogramas, reflejados en un tablero de comunicación que facilita su entrenamiento en estos sistemas no vocales que facilitan la comunicación y el aprendizaje en las personas que presentan esta condición del desarrollo a favor de su inclusión.

Por ejemplo en un tratamiento logopédico se puede trabajar con un pictograma.

Tema: La escuela.

Objetivo: Pronunciar // y /b/ en palabras en diferentes situaciones comunicativas.

Método: Demostrativo.

Medios: Espejo y pictograma relacionado con la escuela.

Material verbal: escuela, pioneros, maestra, libros, libretas, lápices, cuadernos.

Introducción: Saludo, preparación de las condiciones previas y motivación inicial.

¿Te gustan los paseos? Bueno hoy te invito a realizar un paseo por la escuela para conocer sus partes. Orientar el objetivo

A medida que se realiza el paseo se le pregunta: ¿Sabes cómo se llama la escuela?

¿En qué municipio se encuentra? Según paseamos por las partes de la escuela se le preguntará: ¿Dónde nos encontramos? Todo el tiempo el logopeda se apoya en el pictograma.

Pedir que nombre los objetos que observa en cada parte en función de encontrar palabras que tengan el fonema //.

En el aula (cesto de basura, buzón, libretas)

En la dirección (butaca, búcaro)

En la biblioteca (libros, bombillo)

En computación (las bocinas, ventana)

En la enfermería (vacuna)

En la cocina (boniato, bandejas, vaso)

En el patio (la bandera)

Al llegar a cada una de estas partes se debe pedir permiso antes de entrar, saludar y realizar algunas preguntas de ser necesario y despedirse.

Conclusiones: Se realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido de trabajado mediante el apoyo del pictograma.

¿Qué partes de la escuela visitamos?

Di algunas palabras con el sonido /b/ que hayamos mencionado

Menciona algunas de las oraciones elaboradas.

Tarea: Realiza los ejercicios realizados frente al espejo.

Comenta con tu familia el paseo realizado por la escuela.

2.4 Valoración de los resultados de la aplicación de la propuesta

En la constatación final del problema que se investiga según la consulta a especialistas (ver anexo 9), al valorar la propuesta manifiestan su satisfacción por el valor que tiene para la atención educativa a los escolares con LFM y anartria.

A continuación se aprecia la valoración realizada acerca de los diferentes aspectos que se señalan en la tabla:

Aspectos a valorar	MA	A	PA	NA
Fundamentación	7			
Estructura y contenido	2	5		
Sugerencias metodológicas	3	4		

En la fundamentación de la propuesta los 7 especialistas (100%) consideran que es muy adecuada la propuesta. En sus valoraciones destacan que la estrategia de CA señalada favorece la creación de situaciones comunicativas vivenciales para los escolares con LFM y anartria desde sus fundamentos en las diferentes ciencias de la educación. Además, precisan que el tablero de comunicación motiva al escolar a establecer relaciones interpersonales y desarrollar una autoestima favorable.

El cuaderno individual basado en pictogramas entrena al escolar y a la familia para desarrollar la capacidad de comunicación. Asimismo, la selección variada del material verbal para el desarrollo léxico, la que se sustenta en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, la mediación social del desarrollo psíquico.

En cuanto a la estructura y contenido de la propuesta, el 28,5% la valoró de muy adecuada y el 71,4% de adecuada. Los criterios que fundamentaron al respecto están relacionados con su novedad al señalar la condición social del desarrollo, la que orienta el tipo de estrategia a utilizar en la práctica pedagógica, a partir de situaciones comunicativas vivenciales basadas en claves visuales, la anticipación y la representación, la que propicia la búsqueda, utilización y evaluación de la información, por la relación que se produce entre comunicación y aprendizaje.

Con respecto a las sugerencias metodológicas para su introducción en la práctica educativa 3 especialistas (42,8%) consideran la propuesta de muy adecuada y 4 de adecuada (57,1%). Las principales sugerencias estuvieron dirigidas a:

- ✓ Combinar la estrategia de comunicación aumentativa propuesta, con otras como las de carácter tecnológico.
- ✓ Ampliar la propuesta a un grupo de escolares que presentan esta condición del desarrollo.
- ✓ Divulgar la propuesta en diferentes contextos para favorecer el proceso de inclusión educativa.
- ✓ Profundizar en la aplicación de las estrategias de comunicación aumentativa desde la formación inicial.

Después de aplicada la propuesta, en un período de cinco meses, se pudo constatar los cambios producidos en algunos indicadores que evidencian la viabilidad de la estrategia de comunicación aumentativa seleccionada para facilitar la comunicación y el aprendizaje del escolar investigado. Por eso, en el preexperimento en todos los indicadores los resultados se modificaron con respecto al diagnóstico inicial.

En la figura se puede apreciar que los indicadores cambiaron con la aplicación de la estrategia de comunicación aumentativa, se debe destacar que dos indicadores evolucionaron a la categoría de alto.

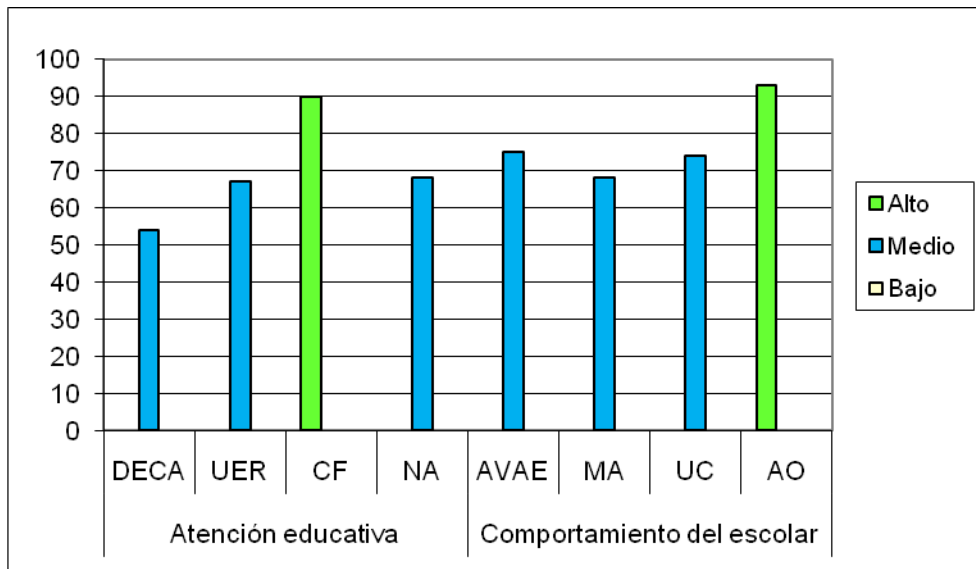


Fig.19 Diagnóstico final

También en la aplicación del estudio de caso, los aspectos más destacados en la evolución del escolar no solo es haber desarrollado su vocabulario en diferentes situaciones comunicativas, sino la elevación de su autoestima por la confianza y seguridad en su maestra logopeda y la del aula, así como la orientación familiar para desarrollar su capacidad comunicativa.

Un aspecto muy importante en la aplicación del estudio de caso y su relación con el preexperimento como parte de las observaciones realizadas y la constatación final fue la manera rápida que evolucionó el escolar con la aplicación de los pictogramas en diferentes situaciones comunicativas.

Conclusiones

1. Los sustentos teóricos y metodológicos que fundamentan la comunicación aumentativa en los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria se evidencian en el empleo de la diversidad de estrategias, las que tienen un valor metodológico y están dirigidas al desarrollo de la capacidad de comunicación para la inclusión educativa.
2. La caracterización del estado actual de la comunicación aumentativa en un escolar con limitaciones físico-motoras y anartria reveló las insuficiencias teóricas y metodológicas en su empleo, las que se manifiestan tanto en la atención educativa como en el comportamiento del escolar en la práctica pedagógica.
3. La estrategia de comunicación aumentativa diseñada tiene como particularidades el empleo del pictograma como elemento representativo, el uso de claves visuales desde la diversidad de formas en que se utiliza, propiciar la anticipación de acciones sobre el entorno mediante situaciones comunicativas que favorezcan el análisis, la comprensión y construcción de textos.
4. La estrategia de comunicación aumentativa aplicada fue valorada de muy adecuada y adecuada por los especialistas, asimismo se evidenciaron resultados cualitativos favorables en el estudio de caso y cambios en los indicadores de las dos dimensiones en el preexperimento, que corrobora su viabilidad y validez científica.

Recomendaciones

1. Continuar profundizando en la temática investigada para perfeccionar el empleo de los sistemas de comunicación aumentativa, en una población significativa de escolares con limitaciones físico-motoras y anartria.
2. Estimular el debate y el intercambio de experiencias del tema de los sistemas de comunicación aumentativa en diferentes contextos que propicien su utilización para la inclusión educativa.
3. Realizar estudios acerca de la temática con el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Bibliografía:

1. Álvarez, C. Metodología a seguir para el estudio de caso como método cualitativo de investigación. 1998 (Folleto digital).
2. Álvarez, C. y otros. Evaluación, diagnóstico y prevención. Curso 5. Maestría en educación especial. Universidad Bolivariana de Venezuela. Centro internacional Miranda. 2010.
3. Azcoaga, J. Del lenguaje al pensamiento verbal. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2003.
4. Basil, C y Puig de la Bellacasa, R: "Comunicación Aumentativa". Curso sobre sistemas y ayudas técnicas de comunicación no vocal. Colección Rehabilitación del INSERSO. Madrid.
5. Betancourt, J. y otros. La comunicación educativa en la atención a niños con necesidades educativas especiales. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2003.
6. Betancourt, J. y otros. Fundamentos de psicología. Primera parte. Textos para estudiantes de las carreras Licenciatura en Educación Especial y logopedia. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2012.
7. Borges, S y otros: Selección de lecturas sobre la Educación Especial en Cuba. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2011.
8. Caperucita Roja: (Sistema de Comunicación Aumentativa y/o Alternativa). Departamento de Deficiencia Motórica del CNEE.
9. Castro, P.L. y otros. La labor preventiva en el contexto familiar. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2010.
10. Colectivo de autores. Sublime profesión de amor. Educación Especial en Cuba. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1996.
11. Chávez, J. A y otros. Acercamiento necesario a la pedagogía general. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2005.
12. Díaz, M. L. Las voces del silencio. Una comunicación sin límites. Consejería de Educación y Cultura. Murcia, España. 2004.
13. Fernández, G y coautores. La Rítmica Logopédica con Elementos de Expresión Corporal en el Tratamiento de la Disartria. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1991.
14. Fernández, G. La atención logopédica en la edad infantil. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2008.

15. Fernández, I. y Vázquez, G. Recursos tecnológicos para el tratamiento logopédico. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2008.
16. Fernández, G. y Rodríguez, X.: Logopedia para las carreras de Logopedia y Educación Especial. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2012.
17. Figueredo, E y otros. Logopedia I. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1984.
18. Figueredo, E y López, M. Técnica del habla. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
19. Figueredo, E y López, M. Temas Logopédicos. Selección de lecturas. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1987.
20. Gadotty, M. La escuela y el Maestro. Ministerio del Popular para la Educación Superior. Centro Internacional Miranda. (2007).
21. Gerospe, J. M y otros. Valoración de la Deficiencia y la Discapacidad en los Trastornos del Lenguaje, el habla y la voz. (Editora. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 1997).
22. Holvoet, J. F y Helmstetter, E. Medical problems of students with special needs: A guide for educators. Boston: College-Hill Press. 1989.
23. Kaplún, M. Una pedagogía de la comunicación. Ediciones de la Torre. Madrid, 1998.
24. Luria, A. R. Las funciones corticales superiores del hombre. Editorial Científico-Técnica, 1982.
25. Mesa, Paulina. Y otros. El trabajo de los Centros de Diagnóstico y Orientación. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2006.
26. Navarro, S: Una concepción pedagógica para el proceso de tránsito a la Educación media superior de los alumnos con LFM. (2006).
27. Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Madrid, España, 2001.
28. Pérez, G., García, G., Nocedo, I., García, M.: Metodología de la investigación educacional. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1996.
29. Puentes, T. Educación de los alumnos con limitaciones Físico-motoras. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2004.
30. Rico, P. La Zona de Desarrollo Próximo. Procedimientos y tareas de aprendizaje. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2003.
31. Rodríguez, X.: Sistemas de comunicación alternativo y/o aumentativo para personas con discapacidad. Revista Educación: La comunicación, siempre. N° 120. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. Enero-abril, 2007.

32. Rodríguez, X. Apuntes de la Comunicación y Cultura de la Comunidad Sorda. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2007.
33. Roméu, A. El enfoque cognitivo, comunicativo y socio-cultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2007.
34. Rodríguez, X. Sistemas de Comunicación Aumentativa para personas con discapacidad. Material de apoyo a la docencia. UCP EJV. 2010.
35. Rodríguez, X. y Cobas, C.L. Los Sistemas de Comunicación Aumentativa en las personas con Necesidades Educativas Especiales. Curso 10. Conferencia científica del CELAE. La Habana, 2010.
36. Rodríguez, X. Los Sistemas de Comunicación Aumentativa en las personas con discapacidad en: Logopedia II parte para estudiantes de las carreras de Educación Especial y Logopedia. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2014.
37. Sales, L. M. La comunicación y los niveles de la lengua. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2007.
38. Sos, A y Sos, L.M. Logopedia Práctica. Editorial Praxis, S. A. España, 1997.
39. Tamarit, J. y otros: "Qué son los sistemas de comunicación aumentativa" en Sistemas Alternativos de Comunicación. Editorial Trotta. Madrid, España. 1993.
40. Torres, S. Sistemas alternativos de comunicación. Manual de comunicación alternativa: sistemas y estrategias. Ediciones Aljibe, Málaga España. (2001).
41. Vigotski, L.S. El problema de la edad, Editorial Progreso, Moscú, 1984.
42. Vigotski, L.S. Fundamentos de Defectología. Tomo V. Editorial Pueblo y educación, La Habana, 1989.

Anexo # 1

Análisis documental

Objetivo: Analizar los documentos que emplea el maestro para el proceso de atención educativa al niño con diagnóstico de limitaciones físico-motoras y anartria.

Aspectos a analizar:

- Estado de la caracterización psicopedagógica del escolar.
- Precisión de la exploración logopédica con su diagnóstico y estrategia general de intervención.
- La utilización de los sistemas de comunicación aumentativa

Documentos empleados por el maestro:

- Expediente psicopedagógico.
- Expediente logopédico.
- Libreta de actividades (análisis del producto de la actividad)

Anexo 2.

Técnica de exploración logopédica.

CENTRO

NOMBRE(S) Y APELLIDOS

EXPEDIENTE CDO

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

SEXO

GRADO

CURSOS DE REPITENCIA

PROCEDENCIA DEL NIÑO

MOTIVO DE CONSULTA (QUEJAS DE PADRES Y MAESTROS)

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE

OTROS DATOS DE INTERES

EXAMEN ESPECÍFICO DEL HABLA

ESTADO DEL APARATO CIRCULATORIO (MOVILIDAD)

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDICIÓN

ESTADO DE LA EXPRESIÓN ORAL

CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA, CARACTERÍSTICAS

VOCABULARIO (VOLUMEN, CALIDAD, SIGNIFICADO)

ESTRUCTURA GRAMATICAL (ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS
MORFOLÓGICAS)

CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRESIÓN

EJECUCIÓN DE ÓRDENES

COMPRESIÓN DE ACCIONES

COMPRESIÓN DE PALABRAS

COMPRESIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

OBSERVACIONES:

ANÁLISIS DE LA PRONUNCIACIÓN Y DE LOS PROCESOS FONEMÁTICOS

FMS POSICIÓN FMS POSICIÓN FMS POSICIÓN FMS POSICIÓN

FMS	I	M	F	FMS	I	M	F	FMS	I	M	F	FMS	I	M	F
A				K				FL				EI			
E				G				GL				EU			
O				J				CL				OI			
I				T				BR				OU			
U				D				PR				IA			
M				N				FR				IE			
P				S				DR				IU			

FMS POSICIÓN FMS POSICIÓN FMS POSICIÓN FMS POSICIÓN

FMS	I	M	F	FMS	I	M	F	FMS	I	M	F	FMS	I	M	F
S				L				TR				IO			
F				R				GR				UA			
CH				RR				CR				UE			
Y				BL				AI				UI			
Ñ				PL				AU				UO			

OBSERVACIONES:

RITMO Y FLUIDEZ DEL LENGUAJE

CARA

CTERÍSTICAS DE LA VOZ (INTENSIDAD, TONO, TIMBRE)

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTO-ESCRITURA

ESCRITURA

CONDUCTA OBSERVADA DURANTE LA PRUEBA

DIAGNÓSTICO LOGOPÉDICO

RECOMENDACIONES

EXAMINADOR

FECHA

Anexo # 3

Observación a clase.

Objetivo: Constatar el empleo de los sistemas de comunicación aumentativa en las diferentes actividades de los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria.

Dimensiones	Indicadores	Criterios de evaluación		
		Alto	Medio	Bajo
Atención educativa	Dominio de las estrategias de comunicación aumentativa			
	Uso de estrategias representativas			
	Establecimiento de un clima de confianza y seguridad			
	Empleo de niveles de ayuda			
Comportamiento del escolar	Adquisición de vivencias con la ayuda externa			
	Estado de la motricidad articuladora			
	Uso de códigos			
	Aceptación de otros niños en el proceso interactivo			

Criterios de evaluación:

Alto: Cuando hay dominio de CA, se establece un clima de confianza y seguridad y se emplean niveles de ayuda que favorezcan el comportamiento del escolar en cuanto a la adquisición de vivencias, el uso de códigos, el desarrollo de la motricidad articuladora y la aceptación de los otros.

Medio: Cuando hay dominio de CA y se establece un clima de confianza y seguridad, pero no se evidencia el empleo de los niveles de ayuda, lo que se revela en las pocas vivencias del escolar a pesar de la aceptación de los otros con respecto a su comportamiento.

Bajo: Cuando se evidencia desconocimiento de la CA y del empleo de niveles de ayuda que inciden en el comportamiento del escolar con respecto a la adquisición de vivencias, el uso de los códigos

Anexo # 4

Entrevista a directivos, maestros

Objetivo: Buscar información acerca del empleo de los sistemas de comunicación aumentativa en escolares con limitaciones físico-motoras y anartria.

1. ¿Qué conoces acerca de los sistemas de comunicación aumentativa?
2. ¿Cuáles utilizas en los escolares con limitaciones físico-motoras y anartria?
3. ¿Cómo estableces un clima de confianza y seguridad con los escolares que presentan limitaciones físico-motoras y anartria?
4. ¿Qué valor le concedes a estos sistemas para el aprendizaje y la preparación para la vida de los escolares?
5. Cómo propicias las ayudas a los escolares para la adquisición de vivencias?
6. ¿Qué recursos utilizas para el desarrollo de la motricidad general y articularia de los escolares?
7. ¿Qué códigos emplean los escolares para comunicarse y cuál es la aceptación por los otros en el proceso interactivo?

Anexo # 5

Entrevista familiar

Objetivo: Buscar información acerca del dominio que tiene la familia de los sistemas de comunicación aumentativa para la educación de su hijo.

1. ¿Cómo se comunica su hijo con los miembros de la familia y la comunidad?
2. ¿Qué conoce acerca de los sistemas de comunicación aumentativa para facilitar la comunicación de su hijo? ¿Cuál emplea?
3. ¿Qué orientaciones recibe por parte de la escuela para facilitar la comunicación de su hijo?
4. A su juicio qué disposición y motivación tiene su hijo para comunicarse con los demás? (se motiva por establecer relaciones con los demás)
5. Comente acerca del estado de la autoestima, las emociones y el aprendizaje escolar de su hijo?
6. Ejemplifique acerca de cómo la familia ayuda a su hijo en la comunicación y el aprendizaje.

Anexo # 6

Existen diferentes metodologías para realizar los estudios de casos. A continuación se presenta la metodología que se aplica con más frecuencia en el contexto de la Educación Especial, basada en los estudios realizados por el Dr. Álvarez, C. y Dr. Akudovich, S. (2006)

Guía para la elaboración del estudio de caso

I .Datos Generales. Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad, sexo, grado o nivel escolar, escuela, dirección particular.

II. Motivo de la selección para el estudio de caso. Se precisan las razones por las cuales el sujeto fue seleccionado para el estudio.

III. Fundamentación de los métodos y técnicas seleccionados para el estudio. Se considera la etapa evolutiva de desarrollo en que se encuentra el sujeto, a partir de los motivos de selección del caso. Debe precisarse su objetivo, los recursos humanos y materiales con que cuenta y el tiempo disponible para la realización del diagnóstico.

IV. Información sobre el sujeto. En los aspectos de su desarrollo se tendrá en cuenta:

Antecedentes patológicos familiares y personales, desarrollo psicomotor y físico, hechos significativos de la conducta y del aprendizaje.

Aspecto biológico: datos de tipo médico (físico, neurológico, sensorial, salud y otros) de utilidad en la planificación de la respuesta educativa. Es importante seleccionar entre la información disponible en relación con los sujetos que presentan distintas necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, en cualquier contexto de actuación.

Aspecto intelectual: información sobre las capacidades básicas (percepción, procesamiento de la información, atención, memoria, procesos de razonamiento), será importante la planificación de la respuesta educativa que oriente la presentación de las tareas, las ayudas, así como la dirección a tomar para potenciar las capacidades.

Aspecto del desarrollo motor: será necesario tener la información sobre sus posibilidades de desplazamiento, control postural, capacidad manipulativa y de movilidad, que orienten sobre las ayudas y cambios a introducir en el entorno escolar.

Aspecto comunicativo: es muy importante profundizar en el estado de los componentes de la lengua, así como en otros lenguajes o sistema que el sujeto utiliza.

Aspectos de adaptación e inserción social: a través de la evaluación en las labores de orientación y seguimiento dentro del contexto educativo, es posible obtener mayor información sobre la relación del alumno con los demás, tanto con los iguales como con los adultos.

Aspectos emocionales: la construcción de una autoimagen positiva, la autoestima, el sentimiento de confianza en uno mismo y en los demás, el grado de bienestar, otros.

Nivel de competencia curricular: implica determinar lo que es capaz de hacer el alumno en relación a los objetivos y contenidos de las diferentes áreas del currículo ordinario. Es importante insistir en una manera de reflejar los criterios de evaluación empleados, lo que es capaz de hacer el alumno y el tipo de ayuda necesaria.

Estilo de aprendizaje y motivación para aprender: se denomina estilo de aprendizaje al conjunto de aspectos que conforman la manera de aprender:

¿Qué se necesita saber?

- En qué condiciones físico ambientales (sonidos, luz, temperatura y ubicación del alumno dentro del aula) trabaja con mayor comodidad.
- En qué áreas, con qué contenidos y en qué tipo de actividades está más interesado, se siente más cómodo, tiene mayor seguridad.
- Cuál es su nivel de atención (en qué momentos del día está más atento, de qué manera podemos captar mejor su atención, duración, tiempo concentrado en una actividad).
- Estrategias que emplea en la resolución de las tareas: reflexivo, impulsivo, recursos que utiliza, tipos de errores más frecuentes, ritmo de aprendizaje.

- Qué tipos de ayuda necesita, si valora su propio esfuerzo, si se siente satisfecho ante su trabajo.
- La motivación para aprender.
- Es una dimensión más del estilo del aprendizaje, es de suma importancia saber qué tareas le motivan más, que metas persiguen y que atribuciones hacen ante los éxitos y los fracasos escolares.

V. Información sobre el entorno que lo rodea.

Contexto escolar

Contexto próximo: aula. El estilo de enseñanza de cada profesor, su forma de elaborar el programa, llevarlo a la práctica, organizar la clase, de relacionarse con sus alumnos y alumnas. Tener en cuenta su evaluación profesional, así como los años de experiencias.

Contexto amplio: centro. La actuación educativa que se pone en marcha en aula no depende únicamente del profesor o la profesora, sino también, en gran medida de las líneas de trabajo planteadas por el colectivo pedagógico del centro.

Contexto socio-familiar. Es muy importante la colaboración con la familia y su activa participación en el proceso pedagógico, ajustando o modificando lo que sea necesario y posible, para ofrecerle la respuesta más adecuada.

La información más útil se agrupa en tres grandes bloques:

- El alumno: su grado de autonomía en la casa y en barrio, hábitos de higiene, alimentación y vestimenta. Las interacciones que establece con la familia, sus aficiones y preferencias.
- La familia: la organización de la vida familiar, su dinámica funcional, sus hábitos, su actitud ante sus hijos con dificultades, el apoyo que le brinda a la solución de sus problemas, el conocimiento que tienen sobre sus particularidades individuales, su grado de colaboración y las expectativas con relación a la escuela, entre otros aspectos de interés. Resulta importante conocer el nivel de integración de la familia y constatar el papel que asumen ante el desarrollo de sus hijos, así como su disposición e intencionalidad por elevar sus potencialidades educativas.
- El entorno social: calidad de la vivienda, recursos existentes en la zona residencial, como parques, centros deportivos, recreativos, culturales y relaciones interpersonales en la comunidad y/o grupos sociales.

VI. Valoración integral de los resultados de la evaluación psicopedagógica. Precisión de potencialidades y necesidades. Se buscarán los aspectos comunes y diversos aportados por cada método aplicado en el estudio, se precisan las potencialidades del desarrollo y las necesidades que deben estar satisfechas.

VII. Conclusiones (Impresión diagnóstica). Se ofrecen las conclusiones generales con la impresión diagnóstica del caso a partir de la valoración integradora y sistémica del sujeto como un todo, relación multidimensional de la etiología con relación a las características del desarrollo y valoración del sistema de influencias (condiciones externas) y las condiciones internas de su personalidad en su relación.

Estudio de Caso:

1- Datos generales

Nombre: Y F R

Fecha de nacimiento: 6 de Abril del 2001.

Edad: 13

Dirección: Peñalver # 21-/. Hoyo y Final. Reparto Peñalver. Guanabacoa. Ciudad de la Habana.

Escuela: Solidaridad con Panamá.

2-Motivo de consulta: Por presentar severas dificultades motrices y del lenguaje.

3- Entorno familiar: El núcleo familiar está compuesto por la madre, el padre, el menor y el abuelo materno, el cual los mantiene por no presentar vínculo laboral. La madre recibe 370 pesos como madre cuidadora. La vivienda se encuentra al final del pasillo, formada por sala, cocina, baño y cuarto, todo con una adecuada higiene y organización. Los efectos electrónicos son: un televisor, un refrigerador, una computadora, una batidora, una plancha, además del módulo entregado por la batalla de ideas. Se establecen buenas relaciones en el hogar, por lo que existe una atmósfera emocional adecuada para potenciar el desarrollo del menor en todas sus áreas. La casa está enclavada en una comunidad semirrural, con pocas opciones recreativas. La maestra refiere que asisten sistemáticamente a la escuela para apoyar el proceso docente educativo y brindan al menor afecto, cubren sus necesidades con responsabilidad sin sobreprotección.

4. Características del entorno escolar: El centro donde se encuentra cursando el 4to grado cuenta con locales de talleres de corte y costura, encuadernación, psicoballet, terapia ocupacional, un gimnasio de rehabilitación física, la enfermería, albergues de hembras y varones, el comedor para ingerir los alimentos y el área de educación física. Existen especialistas en cada uno de estos talleres, maestros y otros agentes educativos que contribuyen a la formación del menor. Se establecen adecuadas relaciones interpersonales entre el menor, sus coetáneos y docentes, aunque existen algunos que en ocasiones no lo comprenden por sus dificultades en el lenguaje.

5- Dinámica del menor seleccionado: Yohan es portador de una parálisis cerebral infantil por disquinesia atetóxica, como factor secundario una disartria, que en su grado más grave se convierte en una anartria. Proviene del Programa Educa a tu Hijo, donde recibió adecuada estimulación de todos los especialistas que lo atendieron. Posee adecuada apariencia personal y un desarrollo físico en cuanto a talla y peso, en correspondencia para la edad. Nunca fue asignado al salón de estimulación temprana del municipio, debido a sus impedimentos motores. Recibió atención por neurología y fisiatría en el Hospital Julio Díaz, con tratamiento medicamentoso y ejercicios de rehabilitación. El menor no padece de ninguna enfermedad, sin embargo es alérgico al calamar. No existen antecedentes patológicos familiares. Deambula en sillón de ruedas, necesitando siempre de alguna persona que lo traslade, debido a sus movimientos involuntarios que le impiden manipular el sillón.

Establece adecuadas relaciones con sus coetáneos y adultos del centro, aunque su comunicación es a través de señas. Psicopedagógicamente se encuentra en la media del grupo. Necesita de ejercicios básicos con el uso del teclado, con el cual toma dictado y requiere de otras ayudas y apoyos para vencer el currículo, por ejemplo, hojas de trabajo, tarjetas, actividades de enlace, marcar, seleccionar, siempre que el objetivo de la actividad lo permita. En Terapia Ocupacional necesita muchas actividades dirigidas al control muscular, al desarrollo de la motricidad fina y gruesa, así como actividades que favorezcan el autovalidismo, por ejemplo, sostener objetos. En las asignaturas se trabajan los objetivos básicos del grado, porque se han ido complejizando los contenidos, y los medios de enseñanza para acceder al currículo, diseñados para él, se quedan por debajo de las exigencias que necesita para resolver la actividad y/o controlar los conocimientos adquiridos.

A pesar de ello muestra interés por aprender, presenta sentido de pertenencia, conoce sus objetos, no admite tener cosas ajenas, ni que otras personas posean las suyas. Mantiene buen porte y aspecto personal, es voluntarioso, alegre, respetuoso, disciplinado.

Parto: La madre refiere que es producto de un embarazo deseado, le daba igual cualquier sexo, recibió atención médica desde las 21 semanas, que fue cuando le detectaron el embarazo, tenía más 22 años de edad. Fue ingresada a los 5 meses en el Hospital Ginecostétrico, conocido como la Fátima, por bajo peso con dieta reforzada. No se pudo realizar la prueba de alfa feto debido a la detección tardía.

Fue un parto Pre término a las 34 semanas, con llanto espontáneo, pesó 4,8 libras, apgar de 9.9. Estuvo en el cunero 20 días hasta que alcanzó el peso, a los tres días le subió la bilirrubina donde le dieron tratamiento por varios días, no fue necesario transfundirlo. A los 2 mese fue ingresado en el Hospital Naval por presentar síntomas de encefalitis viral, permaneciendo en observación durante 3 días.

A los 5 meses fue nuevamente ingresado para hacerse la prueba del citomegalovirus, que arrojó el parásito de la paloma, indicándole suero. Fue dado de alta a los 5 días con rechequeo e indicación de suero cada 3 meses, hasta los 2 años que recibió alta médica. En el área del lenguaje logra emitir los sonidos onomatopéyicos, guturales, inarticulados. Para responder preguntas se auxilia de la mímica con gran logicidad. Es capaz de pronunciar el nombre de la madre, el padre y el suyo. Comprende y ejecuta órdenes sencillas, tiene afectada la apraxia orolingüofacial.

En cuanto al desarrollo de habilidades, aunque logra tirar besos, se le dificulta el paso de una posición articulatoria a otra, a pesar de que se aprecia una leve mejoría y gran interés por las actividades. La audición impresiona entre los límites normales, responde a la voz hablada y cuchicheada, así como a estímulos sonoros por ambos sonidos. El vocabulario pasivo impresiona conservado, el activo carece de expresión oral, por lo que se encuentran afectado todo el componente sonoro del lenguaje.

6- Fundamentación de los instrumentos aplicados. Para valorar el desarrollo psicopedagógico del escolar y elaborar la estrategia de intervención que cumpla las expectativas de sus necesidades educativas especiales, se aplicaron los métodos de investigación teóricos y empíricos siguientes:

- Análisis documental
- Cuarto excluido
- Test de memoria a corto plazo(adaptado por T. Morales)
- Test de atención(adaptado por T. Morales)
- Entrevista a los especialistas.
- Entrevista a la mamá.
- Observaciones.
- Exploración logopédica.

Análisis documental de los expedientes psicopedagógicos y logopédicos: permitieron conocer los datos anamnésicos, la evolución del lenguaje, el desarrollo psicomotor, la evolución del menor desde su entrada al centro, la dinámica familiar y las estrategias de intervención que se han llevado a cabo.

Entrevista a los especialistas: se entrevistó a la maestra del aula, la psicopedagoga y la logopeda. Con ellas se pudo constatar mucha de las informaciones recogidas en los expedientes, así como sus criterios al respecto del caso en cuestión.

Entrevista a la mamá: con el objetivo de conocer datos referentes al proceso de embarazo y parto, evolución del lenguaje, enfermedades padecidas, estimulación que recibió el escolar en los primeros años.

Observaciones: fueron observadas las actividades que se realizan en el día durante dos semanas: tratamientos logopédicos, clases de Lengua Española, clases de Educación Física, horarios de receso y clases de computación.

Cuarto excluido: se le realizó el con el objetivo de explorar el desarrollo del pensamiento.

Prueba de atención: se le realizó el con el objetivo de explorar el estado actual de la estabilidad, el volumen y el nivel de concentración de la atención voluntaria.

Memoria visual: el resultado fue positivo porque recordó 4 de las 7 ilustraciones presentadas. En la **memoria verbal** el resultado no fue suficiente pues hubo que darle hasta un tercer nivel de ayuda por las limitaciones en su lenguaje, solo fue capaz de recordar 3 palabras de 7 tarjetas que se le mostraron.

Exploración logopédica: se utilizó con el objetivo de observar el estado de la comunicación con relación a las dimensiones e indicadores que se investigan y tener argumentos para establecer un diagnóstico logopédico. Estas técnicas se aplicaron siguiendo la metodología indicada y sus resultados sirvieron para precisar las potencialidades y necesidades del niño.

7- Valoración integral de los resultados de la evaluación psicopedagógica.

Precisión de potencialidades y necesidades

Potencialidades

El escolar es capaz de transferir la ayuda en diferentes situaciones comunicativas con el empleo del pictograma y otras estrategias de comunicación aumentativa.

Necesidades

Presenta necesidades en la motricidad fina y gruesa, en el autovalidismo y severas dificultades para la comunicación y el lenguaje, exige del empleo de los sistemas de comunicación aumentativa para acceder al currículo y como parte de su preparación para la vida en condiciones de inclusión.

8- Diagnóstico Explicativo.

Escolar que presenta trastornos severos en la motricidad general y articulatoria, como consecuencia de una parálisis cerebral que afecta la comunicación y el lenguaje, se enmarca en una disartria severa que se expresa en una anartria. Se afecta todo el componente sonoro del lenguaje y todos los niveles de la lengua. Además, procede de una familia funcional.

Anexo # 7

Cuaderno individual

TAREAS

1. Presentación del tema a tratar
2. Se establece una conversación mediante los elementos representativos del sistema para su aprendizaje.
3. Se estimula al usuario en las respuestas adecuadas en coherencia con las preguntas que revelan su comprensión.
4. Se enfatiza en las acciones a realizar para el desarrollo del pensamiento lógico-verbal.
5. Se entrena al usuario en la retención de la información a partir de ejercicios de memorización del tema.
6. Se usa como medio fundamental para la realización de actividades docentes como: marcar con una X, señalar, ejercicios de verdadero o falso, colorear, rellenar, circular, otros.
7. Práctica sistemática con el empleo del tablero de comunicación mediante el cuaderno individual.

Observaciones

En la medida en que el usuario se va entrenando en el empleo de esta estrategia comunicativa, se complejiza el nivel de comprensión y análisis de la situación comunicativa, así como de las propias producciones del escolar en los diferentes contextos, que evidencien la solidez en su aplicación.

Su aplicación no es solo en el tratamiento logopédico, sino en el salón de clases y en el contexto familiar como vía para la comunicación y el acceso al aprendizaje. Por eso es importante orientar a todos los agentes de socialización para favorecer este proceso. Se trata de utilizar esta estrategia con el propósito de desarrollar la capacidad de comunicación por su implicación en el aprendizaje y en la formación de la personalidad.

A continuación se presentan los diferentes tableros de comunicación propuestos.

Fig.1 Anticipación de acciones para almorzar



Fig.2 Anticipación de acciones para merendar



Fig.3 Acciones a realizar en la escuela y con la familia

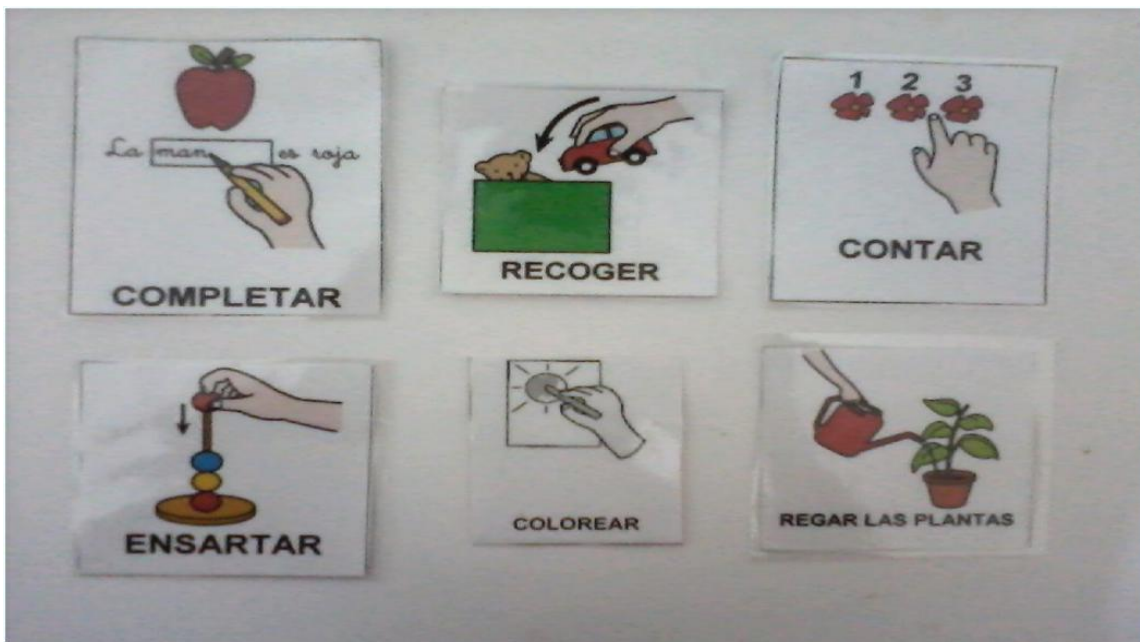


Fig.4 Acciones relacionadas con el contexto familiar



Fig.5 Útiles del comedor



Fig.6 Un paseo al zoológico



Fig.7 Útiles para el trabajo con la motricidad



Fig.8 Las expresiones del rostro

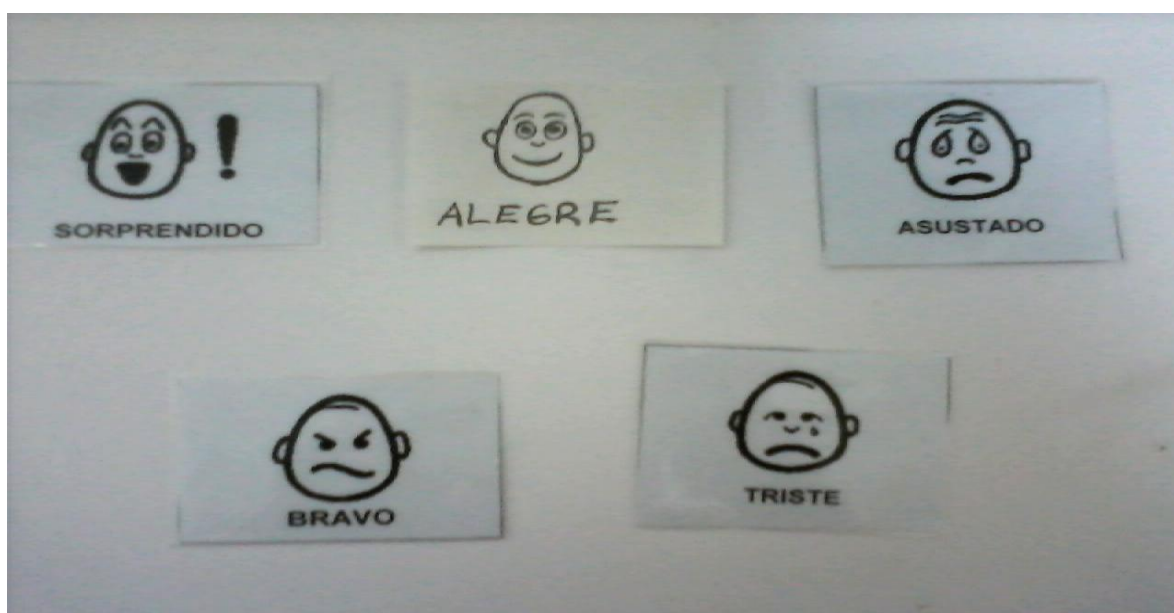


Fig.9 Aseo personal

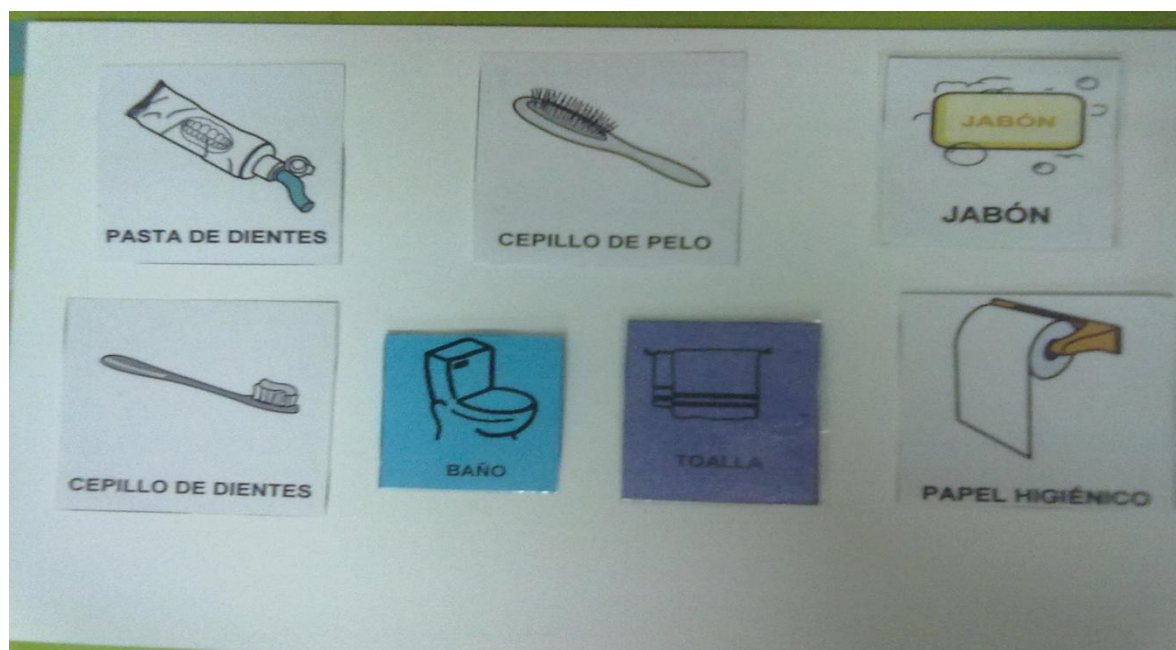


Fig.10 Los saludos



Fig.11 Generalizaciones



Fig.12 Calendario de actividades

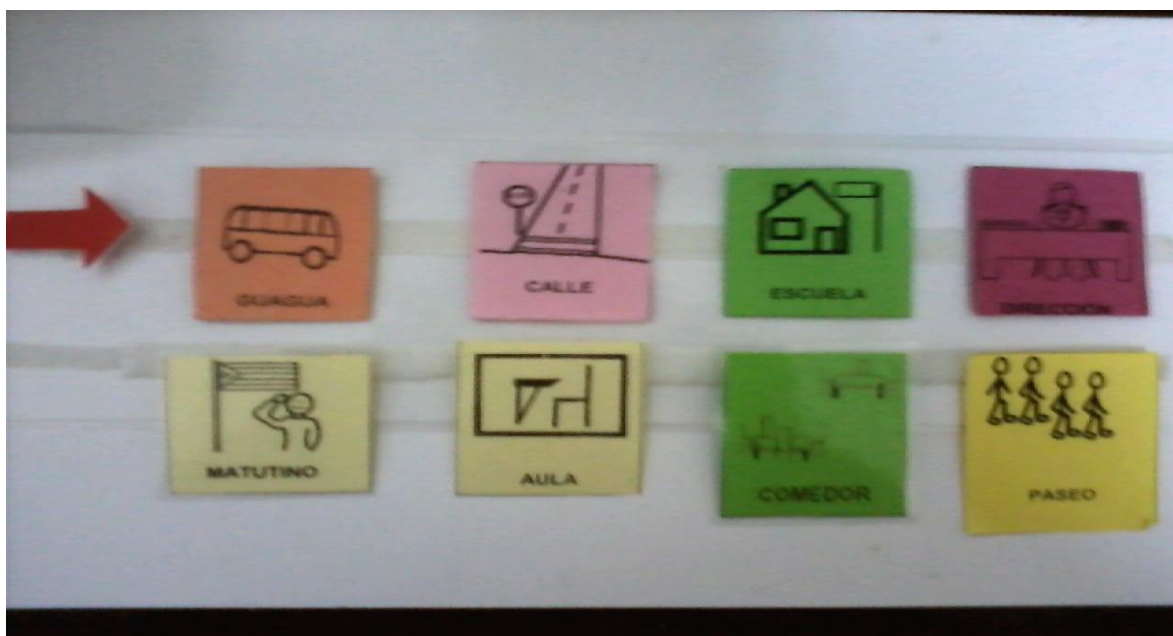


Fig.13 Yo quiero ...

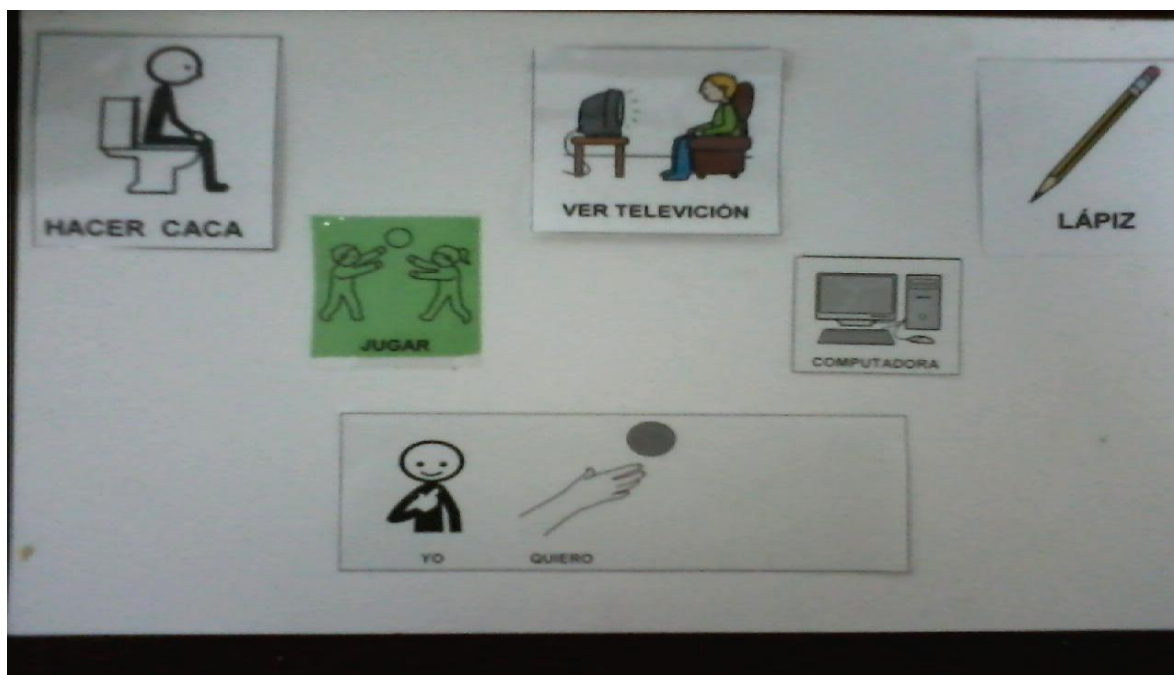


Fig.14. Otras acciones a realizar



Anexo # 8

Encuesta a especialistas

La encuesta que a continuación le presentamos, tiene como objetivo obtener criterios valorativos sobre las estrategias de comunicación aumentativa para escolares con limitaciones físico-motoras y anartria.

Esperamos su colaboración para perfeccionar la propuesta educativa.

1. Marque con una (x) su perfil profesional.

☐

Docente de Ed. Especial

☐

Profesor de la UCP

☐

Maestro logopeda

2. Años de experiencia en la atención a escolares sordos que cursan 3ro y 4to grado.

☐

De 5 a 10 años

☐

De 10 a 15 años

☐

Más de 15 años

3. De acuerdo con su experiencia profesional y después de analizar las estrategias de comunicación aumentativa para escolares con limitaciones físico-motoras y anartria, emita su criterio a partir de los aspectos que aparecen en la tabla.

Aspectos a valorar	MA	A	PA	NA
Fundamentación				
Estructura y contenido				
Sugerencias metodológicas				

Sus criterios serán altamente valiosos para la tarea de perfeccionamiento.

Muchas gracias por su colaboración.